SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento Modelo 2015

Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento Modelo 2015

Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)

Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)

Primera edición 2015

D.R. © Secretaría de Salud
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Información en Salud
Av. Paseo de la Reforma No. 450, Piso 11
Col. Juárez, 06600, México, D.F.

Página Web: http://www.dgis.salud.gob.mx
Correo electrónico: dgis@salud.gob.mx

Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación, siempre y cuando se cite la fuente.

Cita recomendada: Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento. Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Dirección General de Información en Salud. Secretaría de Salud. México, 2015.

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

Sistema Nacional de Salud

Secretaría de Salud
Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Lic. Laura Vargas Carrillo
Titular del Organismo

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dr. José Antonio González Anaya
Director General

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Dr. Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Encargado de Dirección General

Programa IMSS Prospera
Dra. Frinné Azuara Yarzábal
Jefa de Unidad del Programa IMSS Prospera

Petróleos Mexicanos
Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

Secretaría de Marina
Armada de México
Contralmirante SSN M.C. Ped. Rafael Ortega Sánchez
Director General Adjunto de Sanidad Naval

Secretaría de la Defensa Nacional
C. General de Brigada M.C. Dr. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Act. Miguel Juan Cervera Flores
Director General de Estadística Sociodemográfica

Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud (CTESS)

Secretaría de Salud
Presidente
Lic. Juan Carlos Reyes Oropeza
Director General de Información en Salud

Secretaría de Salud
Dirección General de Información en Salud
Secretario de Actas
Lic. José Antonio Sifuentes Badillo
Subdirector de Integración y Difusión de la Información

INEGI
Secretaria Técnica
Dra. Leonor Paz Gómez
Asesora en la Generación de Productos Censales
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas

IMSS
Vocal
Lic. Ángel Campos Hernández
Titular de la División de Información en Salud
Suplente
Lic. Julieta Paredes vidales
Coordinador de Programas

IMSS-Prospera
Vocal
Lic. Oralia Jandette Zárate
Coordinadora de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios
Suplente
Mtra. Martha Alicia Barajas Boyso
Titular de la División de Planeación, Estratégica y Evaluación.

ISSSTE
Director de Finanzas
Vocal
Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda
Suplente
Ing. Rogelio Morales Virgen
Jefe de Servicios de Estadística Institucional

PEMEX
Vocal
Dra. Carmen Namihira Alfaro
Coordinadora de Especialidad Área de Evaluación de la Gestión y Mejora de Procesos
Suplente
Lic. Jesús Alberto Salinas Hernández
Encargado de la Unidad de Informática Médica

PEMEX
Suplente
Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
Jefe de la Unidad de Planeación, Normatividad e Innovación
Suplente
Dr. Felipe Velázquez Canchola
Gerente de Servicios Médicos

Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud (CTESS)

SEDENA
General de Brigada M.C.
Daniel Gutiérez Rodríguez
Director General de Sanidad
Vocal
C. General Brigadier Médico Cirujano
Eduardo Sirahuen Neri Ruz
Subdirector Administrativo de la Dirección General de Sanidad
Suplente
C. Teniente Coronel M.C.
Manuel Canseco Álvarez
Jefe de la Sección de Planes y Programas

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Vocal
Lic. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social.
Suplente
Lic. Alberto Antonio Mares Chalela
Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social

SEMAR
Vocal
C. Tte. Nav. SSN. CD. MSP.
Max Ricardo Trigo Madrid
Subdirector de Salud Publica
Suplente
C. Tte. Corb. SSN. ET. SP.
Mayra Sofía Valerio Cabrera
Salud Publica
Ing. en Inf. Enrique Hernández González
Jefe de Departamento de Bioestadística

SNDIF
Vocal
Dr. Ricardo Camacho Sanciprián
Director General de Rehabilitación
Suplente
Dra. María Virginia Rico Martínez
Directora de Rehabilitación

DGE
Vocal
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General
Suplente
Dr. Arturo Revuelta Herrera
Director de Información Epidemiológica

CONAPO
Director General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva
Suplente
Dra. María de la Cruz Muradás Troitiño
Directora de Análisis Estadístico e Informática
Lic. María Felipa Hernández López
Subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales

DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES FEDERALES DE REFERENCIA
Vocal
Dr. José Antonio Moreno Sánchez
Director General Adjunto de Desarrollo Gerencial Corporativo
Suplente
Ing. María de Lourdes Gutiérrez García
Directora de Apoyo a la Estratégia de Calidad

RENAPO
Vocal
Ing. José Antonio Rueda Cuautle
Director General Adjunto de Coordinación de Operación Política y Alianzas Estratégicas.
Suplente
Lic. Claudia Hernández Medina.
Directora de Coordinación Interinstitucional

Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud (CTESS)

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. (Seguro Popular)
Titular
Lic. Elizabeth Vilchis Pérez
Directora General de Afiliación y Operación
Vocal
Mtra. Erika Cervantes Flores
Subdirectora de Planeación

CCINSHAE SSA
Vocal
Dr. Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Suplente
Dr. Cosme Suárez Ortiz
Dirección General de Coordinación de los Institutos Nacionales

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Vocal
Dirección General de Evaluación del Desempeño
Suplente
Lic. Rodrigo Espinosa de la Peña
Director de Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud

ANHP
Vocal
Lic. Álvaro López Aldana
Director Jurídico del Centro Médico ABC
Suplente
Lic. Lariza Tovar García
Gerente Administrativo de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, A.C.

ASOCIACIÓN HOSPITALES
Vocal
Dr. Francisco Hernández Torres
Presidente de Asociación Mexicana de Hospitales
Suplente
Lic. Jesús Guillermo Ávila Valdés
Asesor

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Vocal
Lic. Oscar Rendón Sarabio
Gerente de Salud y GMM

CRUZ ROJA MEXICANA
Vocal
Ing. José Daniel Lozano Aguilar
Director General
Cruz Roja Mexicana
Suplente
Lic. Juan Estrada Miranda
Coordinación de Delegaciones
Dirección de Delegaciones
Lic. Rafael Becerril Díaz
Coordinador Nacional del Restablecimiento del contacto entre familiares

UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Vocal
Dra. María Cristina Gutiérrez Delgado
Directora General Adjunta de Economía y Salud
Suplente
Mtra. María Quintana Citter
Directora de Salud y Desarrollo Económico

Secretaría de Salud

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Dr. Eduardo González Pier
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Gabriel Jaime O´shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Guillermo Miguel Ruíz-Palacios Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Dr. Ernesto Héctor Monroy Yurieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Fernando Gutiérrez Domínguez
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Lic. Carlos Sandoval Leyva
Director General de Comunicación Social

Lic. Juan Carlos Reyes Oropeza
Director General de Información en Salud

Dirección General de Información en Salud (DGIS)

Lic. Juan Carlos Reyes Oropeza
Director General de Información en Salud

Mtra. Aline Patricia Jiménez Romero
Directora de Sistemas de Información de Servicios de Salud

Mtro. Carlos Lino Sosa Manzano
Director de Información de Recursos para la Salud

Lic. María Almendra Castro Macedo
Directora de Coordinación Normatividad y Difusión

Lic. Jaqueline Alcantara Quintana
Directora de Proyectos

Lic. Bonifacio Rugerio Escobar
Director de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos

C.P. Edna Giomara Pérez Ponce
Coordinadora Administrativa de la Dirección de Información en Salud

Dra. Noemí Lam Osnaya
Subdirectora de Información Institucional

Lic. José Antonio Sifuentes Badillo
Subdirector de Integración y Difusión de la Información

Mtro. Oscar Santiago Salinas
Subdirector de Información Financiera

Mtra. Ana María Ornelas Mendoza
Subdirectora de Información de Recursos Humanos y Materiales

Lic. Gaspar Nino Ibarra Espinosa
Subdirector de Información de Medición de Salud

Lic. Ángel González Serrano
Subdirector de Servicios Electrónicos Hospitalarios

Lic. Jaziel González Flores
Subdirector de Atención Primaria

T.S.U. Alicia Mercado Sandoval
Jefa de Departamento de Procesamiento de la Información Hospitalaria

Ing. Luis Enrique Puente Lozano
Jefe de Departamento de Diseño de Sistemas de Información

Lic. Irving Luna Cruz
Jefe de Departamento de Coordinación Sectorial

C.P. Monserrat Pérez Pérez
Jefa de Departamento de Gestión Financiera

Ing. Cynthia Liliana Martínez Cabello
Jefa de Departamento de Soluciones Electrónicos en Salud

Lic. Yovany de Jesús López Serrano
Jefe de Departamento de Seguridad de la Información

Agradecimientos

La Dirección General de Información en Salud, responsable de la elaboración del presente manual, agradece a los miembros del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud (CTESS) y del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) que contribuyeron para el enriquecimiento en la actualización del presente manual:

Secretaría de Salud
- Dirección General de Epidemiología
- Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia
- Dirección General de Evaluación del Desempeño
- Instituto Mexicano del Seguro Social

Programa IMSS-Progresa
Instituto de Seguridad y Seguros Sociales de los Trabajadores del Estado
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Petróleos Mexicanos
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Secretaría de Gobernación
- Registro Nacional de Población e Identificación Personal
- Consejo Nacional de Población

Asociación Nacional de Hospitales Privados

Asimismo se hace extensivo el agradecimiento al personal de Estadística, de los diversos niveles administrativos en los Servicios Estatales de Salud, quienes con su experiencia cotidiana han colaborado también a enriquecer el presente manual.

En particular, se reconoce el apoyo y colaboración de las siguientes personas para la elaboración y revisión del documento:
Aline P. Jiménez Romero, Gaspar N. Ibarra Espinosa, Luis E. Puente Lozano, Miguel Ángel Garrido Rodríguez, Guadalupe N. Chávez Arciniega, Josefina Navarrete Nieto, María C. Souza Contreras, Rodolfo Alanís Fuentes y Bertha Vázquez Sierra.

Índice

I. Introducción 19
II. Marco Jurídico 21
III. Lineamientos para la expedición del Certificado de Nacimiento 23
IV. Lineamientos para el manejo, control y uso del Certificado de Nacimiento 27
V. Lineamientos en caso de cancelación, robo o extravío 30
VI. Formato del Certificado de Nacimiento 32
Frente 32
Reverso 33
Representación impresa de la versión electrónica del Certificado de Nacimiento 34
VII. Descripción del Certificado de Nacimiento 35
1. Datos de la madre (de la pregunta 1 a la 16) 35
2. Datos del nacido vivo y del nacimiento (de la pregunta 17 a la 30) 36
3. Datos del certificante (de la pregunta 31 a la 37) 36
4. Otros métodos de identificación 37
5. Instrucciones de llenado generales y específicas 37
6. Fe de erratas 37
VIII. Llenado del Certificado de Nacimiento 38
Consideraciones previas al llenado 38
Instrucciones específicas del llenado de cada pregunta 41
1. Datos de la madre 41
2. Datos del nacido vivo y del nacimiento 56
3. Datos del certificante 66
4. Otros métodos de identificación 73
5. Fe de erratas 74
IX. Glosario de términos y abreviaturas 78
X. Bibliografía 88

I. Introducción

Para mejorar la condición de salud de la población materno-infantil, es preciso evaluar continuamente la efectividad de los programas de salud y detectar las necesidades de servicios y recursos médicos dirigidos a esta población; para ello resulta imprescindible contar con información confiable de los nacidos vivos ocurridos en el país, de las condiciones de su nacimiento, así como de la atención y salud tanto del nacido vivo como de la madre.

En este sentido; anteriormente la información provenía de los nacimientos registrados publicados por el INEGI, de las proyecciones de CONAPO, así como de encuestas; sin embargo estas fuentes no satisfacían las necesidades de información del SNS. De tal forma que a partir de septiembre de 2007, después de más de una década de trabajo interinstitucional coordinado por la DGIS, la Secretaría de Salud instituyó el Certificado de Nacimiento como el formato único nacional, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho, haciendo de éste un requisito para la inscripción de un nacimiento ante el Registro Civil (Bases de Colaboración SEGOB-SALUD, 02/05/07 y LGS, DOF-(24/04/13).

A la par del Certificado, se instituyó el SINAC como parte del SINAIS, con la función de integrar y difundir las estadísticas obtenidas a partir de la información contenida en el Certificado de Nacimiento, además de regular y vigilar los procesos de operación respectivos. Desde el primer año completo posterior a su implementación (2008), hasta el último con información consolidada (2014) los resultados a nivel nacional han rebasado las expectativas; lo cual ha sido reconocido, al ser determinada en el marco del Sector Salud como Información de Interés Nacional INEGI, DOF-(23/05/13), lo que entre otras cosas implica que los indicadores de Salud que involucren información sobre nacidos vivos (como la RMM, la TMI y las coberturas de vacunación de menores de un año) deben calcularse con información del SINAC.

De esta manera, es necesario que la información producida mediante el Certificado de Nacimiento sea de calidad. En apoyo a ello, previo a la implementación del Certificado de Nacimiento, la DGIS como instancia responsable de establecer el diseño y contenido de los certificados para generar estadísticas vitales, así como de su distribución, control y supervisión (fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud), elaboró la primera versión del Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento, con el objetivo de guiar al certificante en el correcto llenado de cada una de las variables que éste contiene y darle a conocer los principales lineamientos relacionados con la expedición y uso del mismo.

Con el cambio a la Ley General de Salud, la expedición del Certificado de Nacimiento es obligatorio, como se menciona en Ley General de Salud publicada en el DOF (24/Abr/2013) fracción I Bis del artículo 389 y los artículos 389 Bis y 389 Bis 1, y los dos últimos párrafos al artículo 392.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.12 de la NOM-035-SSA3-2012, el Certificado de Nacimiento debe actualizarse quinquenalmente de acuerdo a las necesidades del SNS; de esta manera, en 2010 tuvo su primera revisión y ahora en 2015 la segunda; en consecuencia a lo anterior el Manual citado también ha sufrido modificaciones, siendo el fin del presente documento la actualización correspondiente al modelo 2015 del Certificado.

II. Marco Jurídico

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-XII-1976, última reforma publicada DOF 17-VI-2009 (artículos 2, 26 y 39).

- Bases de Colaboración suscritas por la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Salud para realizar acciones que garanticen el registro inmediato de los nacimientos y defunciones que ocurran en el territorio nacional, celebradas el 2 de mayo de 2007.

- Ley General de Salud publicada en el DOF (24/abr/2013) fracción I Bis del artículo 389 y los artículos 389 Bis y 389 Bis 1, y los dos últimos párrafos al artículo 392.

- Acuerdo por el que se dan a conocer los modelos que se utilizarán como formatos para la expedición del Certificado de Nacimiento, publicado en el DOF (27/ago/2014).

- Acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI publicado en el DOF (23/may/13) en donde se determina como Información de Interés Nacional al SINAC en el marco del sector salud.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

- DOF 11-VI-2002, última reforma publicada DOF 06-VI-2006.

- Ley de Información Estadística y Geográfica. DOF 30-XII-1980, Ley Abrogada a partir del 15-VII-2008 por Decreto DOF 16-IV-2008.

- Código Civil Federal DOF 26-V-1928, última reforma 28-01-2010.

- Códigos Civiles de las entidades federativas, vigentes.

- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. DOF 19-I-2004, última reforma 29-XI- 2006 (artículos 2 apartado B fracción VIII y 24 fracciones III y VIII).

- Reglamentos de los Registros Civiles de las entidades federativas.

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF 07-XII-2009.

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

- Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en Materia de Información en Salud. Publicada el 30/ene/2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del nacido vivo. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.

- Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. DOF 07-XII-2009.

- Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. DOF 20-II-2004.

- Norma Técnica sobre Domicilios, INEGI. DOF 12-XI-2010.

III. Lineamientos para la expedición del Certificado de Nacimiento

- Las estadísticas de Nacimientos que elaboran los integrantes del SNS se basan en los nacidos vivos ocurridos, cuya fuente de información es el Certificado de Nacimiento.

- Esta información es utilizada para fines epidemiológicos y estadísticos, para la planeación, asignación de recursos y la evaluación de los servicios de atención a la salud y de los programas implementados por los integrantes del SNS.

- Para todo nacido vivo cuyo nacimiento haya ocurrido en territorio nacional es obligatoria su certificación, para lo cual debe utilizarse el formato vigente del Certificado de Nacimiento.

- Los nacidos vivos cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero quedan excluidos de la expedición del Certificado de Nacimiento.

- Para todo nacido vivo cuyo nacimiento haya ocurrido en territorio nacional, el Certificado de Nacimiento es requisito indispensable para el trámite del Acta de Nacimiento.

- El Certificado de Nacimiento debe ser expedido por única vez a todo nacido vivo en territorio nacional (independientemente de la nacionalidad o situación legal de los padres), en forma gratuita y obligatoria, por un médico con cédula profesional o por la persona facultada por la autoridad sanitaria correspondiente.

- Antes de su expedición es indispensable que el certificante haya corroborado el nacimiento, el vínculo madre-hijo(a) y verificado la identidad de la madre mediante una identificación oficial, o a falta de esta última, con el documento respectivo expedido por

la autoridad competente (Jefe Municipal, Comisariado Ejidal, Consulado, etc.).

- El Certificado de Nacimiento debe expedirse según las circunstancias que acompañen al nacimiento de conformidad con lo siguiente:

1. Si el nacimiento ocurrió en una unidad médica del SNS, el Certificado de Nacimiento debe ser expedido obligatoriamente dentro de la unidad en las primeras veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento, por el médico que atendió al nacido vivo después del parto.
2. En este caso el Certificado de Nacimiento debe ser entregado a la madre (o quién corresponda a falta de ésta) al egreso de la misma o antes de transcurridas veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento, lo que ocurra primero.
3. Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del SNS y fue atendido con la asistencia de una partera facultada por alguna institución del SNS para expedir el Certificado de Nacimiento, ésta debe emitirlo dentro de las primeras veinticuatro horas después de ocurrido el nacimiento y entregarlo inmediatamente a la madre (o quien corresponda a falta de ésta).

- Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del SNS y fue atendido por personal no facultado para la expedición del Certificado de Nacimiento:

1. Si la madre recibió atención prenatal en una unidad médica de alguna institución del SNS, a solicitud de la madre, dicha institución es la responsable de expedir el Certificado, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por el certificante.
2. Si la madre no recibió atención prenatal, es responsabilidad de los SESA establecer los mecanismos que garanticen la expedición del Certificado de Nacimiento, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por

el certificante.

3. Si el vínculo madre-hijo no puede ser constatado por el certificante, se debe acudir a la autoridad competente (se recomienda solicitar apoyo al DIF), quien debe corroborar dicho vínculo; una vez hecho lo anterior es responsabilidad de los SESA establecer los mecanismos que garanticen la expedición del Certificado de Nacimiento.

- En caso de fallecimiento de la madre del nacido vivo, el familiar responsable debe presentar una identificación oficial que acredite su persona y la relación madre, además debe mostrar el Certificado o Acta de Defunción de la madre.
- En situación de adopción o de maternidad subrogada, el Certificado Nacimiento debe expedirse a nombre de la madre gestante del nacido vivo. La contravención a lo dispuesto en este lineamiento será sancionado conforme a las penas a que se hagan acreedores de conformidad a lo establecido en la legislación penal vigente de cada entidad federativa, y tratándose de servidores públicos, además a lo señalado en las Leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos que correspondan.
- Consulte la historia clínica de la madre y los documentos de identificación de ésta para el correcto llenado del Certificado. En caso de no existir la historia clínica auxíliese con la información proporcionada por la madre y en caso de complicación, discapacidad o fallecimiento de ésta acuda al padre del nacido vivo o a los familiares (de preferencia directos).
- El Certificado de Nacimiento por ningún motivo amparará un nacimiento ocurrido antes de su implementación (1° de septiembre de 2007); en este caso, la madre, los familiares o el propio interesado tendrá que acudir directamente al Registro Civil para que se le indique el procedimiento a seguir para tramitar el Acta de Nacimiento correspondiento.

- Toda persona autorizada por la Secretaría de Salud, para expedir un Certificado de Nacimiento debe estar capacitada para su correcto llenado y para efectos de las disposiciones jurídicas aplicables, es considerada responsable de la información contenida en el mismo.

IV. Lineamientos para el manejo, control y uso del Certificado de Nacimiento

- La entrega del Certificado de Nacimiento no debe ser condicionada por motivo alguno.

- El Certificado de Nacimiento está conformado por un original y dos copias.
- Con objeto de asegurar la integración de la información y el registro de los nacidos vivos ocurridos se establece lo siguiente:

I. El Certificado original (hoja blanca) será entregado a la madre del nacido vivo con la indicación de presentarlo ante el Registro Civil, como prueba documental de la ocurrencia del nacimiento, para la obtención del Acta de Nacimiento respectiva.

II. La primera copia (hoja rosa) debe permanecer en la unidad médica en la que se expidió el Certificado para fines administrativos de la misma, anexándose al expediente clínico de la madre.

III. La segunda copia (hoja azul) debe ser recolectada por el área responsable de este proceso y entregada al área de captura respectiva para garantizar la integración de la información en el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC); una vez capturada, esta área debe archivar la copia para asegurar su disponibilidad, (que de acuerdo al Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Secretaría de Salud, página 35, Clave 11C.9 Sistema Nacional de Información Estadística, se deben conservar por 3 años en archivo de trámite, 3 años en archivo de concentración) y en caso necesario, para una revisión posterior.

El área de captura, en primera instancia debe estar ubicada en la misma unidad médica, o en su defecto en la jurisdicción sanitaria correspondiente, en el área de estadística de cada institución o bien en los Servicios Estatales de Salud.

IV. Para el caso de los nacimientos certificados fuera de una unidad médica, las dos copias (rosa y azul) deben ser entregadas por el personal autorizado que haya expedido el Certificado de Nacimiento a la instancia que le proporcionó los formatos, la cual se hará cargo del resguardo de la primera copia y de entregar la segunda copia al área de captura que corresponda.

- Al entregar el Certificado de Nacimiento se le debe aclarar a la madre o familiares del nacido vivo que este documento NO SUSTITUYE AL ACTA DE NACIMIENTO, por lo que no debe ser utilizado como complemento para fines legales o administrativos, por lo que deberán acudir a la brevedad al Registro Civil para obtener el Acta de Nacimiento correspondiente. Así mismo, se le debe informar a la madre o a los familiares, que en caso de no ser derechohabiente de ninguna institución de seguridad social, el nacido vivo tiene derecho a su afiliación al Seguro Popular Siglo XXI, para lo cual deben acudir al módulo del Seguro Popular con su Certificado de Nacimiento original.
- En ausencia del Acta de Nacimiento, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán utilizar provisionalmente el Certificado de Nacimiento para fines de afiliación a los programas de salud.
- Al entregar el Acta de Nacimiento, el Registro Civil debe recoger el Certificado original, marcándolo con la leyenda 'REGISTRADO' y resguardándolo posteriormente en el apéndice respectivo.
- Los datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos de Protección de Datos Personales.
- Los SESA, son responsables ante la DGIS del estricto control y uso adecuado de los Certificados de Nacimiento foliados que le fueron proporcionados por la misma en la dotación correspondiente y de coordinar el retiro de los formatos obsoletos cuando ésta así lo indique. De la misma manera todo

establecimiento de una institución del SNS, persona o instancia contemplada en la distribución de Certificados de Nacimiento, es a su vez responsable ante los SESA, del estricto control y uso adecuado de los Certificados de Nacimiento foliados que le fueron asignados.

- Las instancias y personas contempladas en la distribución de Certificados de Nacimiento deben entregar mensualmente en medio electrónico, a las autoridades de los SESA responsables de la distribución de los mismos, un listado con el control de los Certificados de Nacimiento foliados que les fueron asignados, indicando en éste el estatus que guarda cada folio (en resguardo, expedido, cancelado, extraviado o robado). De igual forma los SESA deben entregar a la DGIS, mensualmente y en medio electrónico, el control de los Certificados de Nacimiento foliados correspondiente a su entidad.
- El profesional de la salud o persona facultada por la autoridad sanitaria correspondiente que expida un Certificado de Nacimiento debe estar capacitada para su correcto llenado y es considerada responsable de la información contenida en el mismo para los efectos de esta norma y demás disposiciones jurídicas aplicables. Cualquier variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un Certificado de Nacimiento, es objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
- Los SESA deben prohibir a cualquier certificante, temporal o definitivamente según la gravedad o reincidencia, la expedición de Certificados de Nacimiento y suspenderle la entrega de formatos, cuando se detecten anomalías en su uso y manejo, desviaciones con respecto a los lineamientos establecidos en el presente manual y demás disposiciones jurídicas aplicables o calidad deficiente de la información contenida en los mismos.

V. Lineamientos en caso de cancelación, robo o extravío.

- Todas las instancias y personas contempladas en la distribución de Certificados deben entregar mensualmente a las autoridades de los SESA responsables de la distribución, los Certificados cancelados (el original y las dos copias) mediante oficio, adjuntando a éste una relación de los folios y el motivo de cancelación respectivo. Posteriormente los SESA deben proceder de acuerdo al Manual para la Operación de Archivos Administrativos, solicitando a su Centro de Documentación Estatal, vía oficio, la destrucción de los mismos y enviando a la DGIS copia de dicho oficio. Así mismo, los SESA deben dar aviso inmediato al Registro Civil de la entidad a fin de que éste proceda a boletinar los folios cancelados.

- Para todos los niveles de distribución en caso de robo o extravío de formatos del Certificado de Nacimiento, se debe seguir el siguiente procedimiento:

  I. El área que tenga bajo su resguardo los formatos del Certificado de Nacimiento es la responsable de los mismos y por lo tanto es quien debe levantar de manera inmediata una acta administrativa de hechos ante el Departamento Jurídico de su Institución, así como la respectiva denuncia de hechos ante el Ministerio Público por el robo o extravío de los formatos. En ambos casos debe quedar asentado la cantidad y los números de folios de los Certificados faltantes.

  II. Una vez presentada la denuncia, el área que tenga bajo su resguardo los formatos del Certificado de Nacimiento, debe avisar inmediatamente a los Servicios Estatales de Salud mediante oficio y correo electrónico, anexando copia de la denuncia.

  III. Los SESA deben de igual manera avisar inmediatamente por oficio y correo electrónico al Registro Civil Estatal para

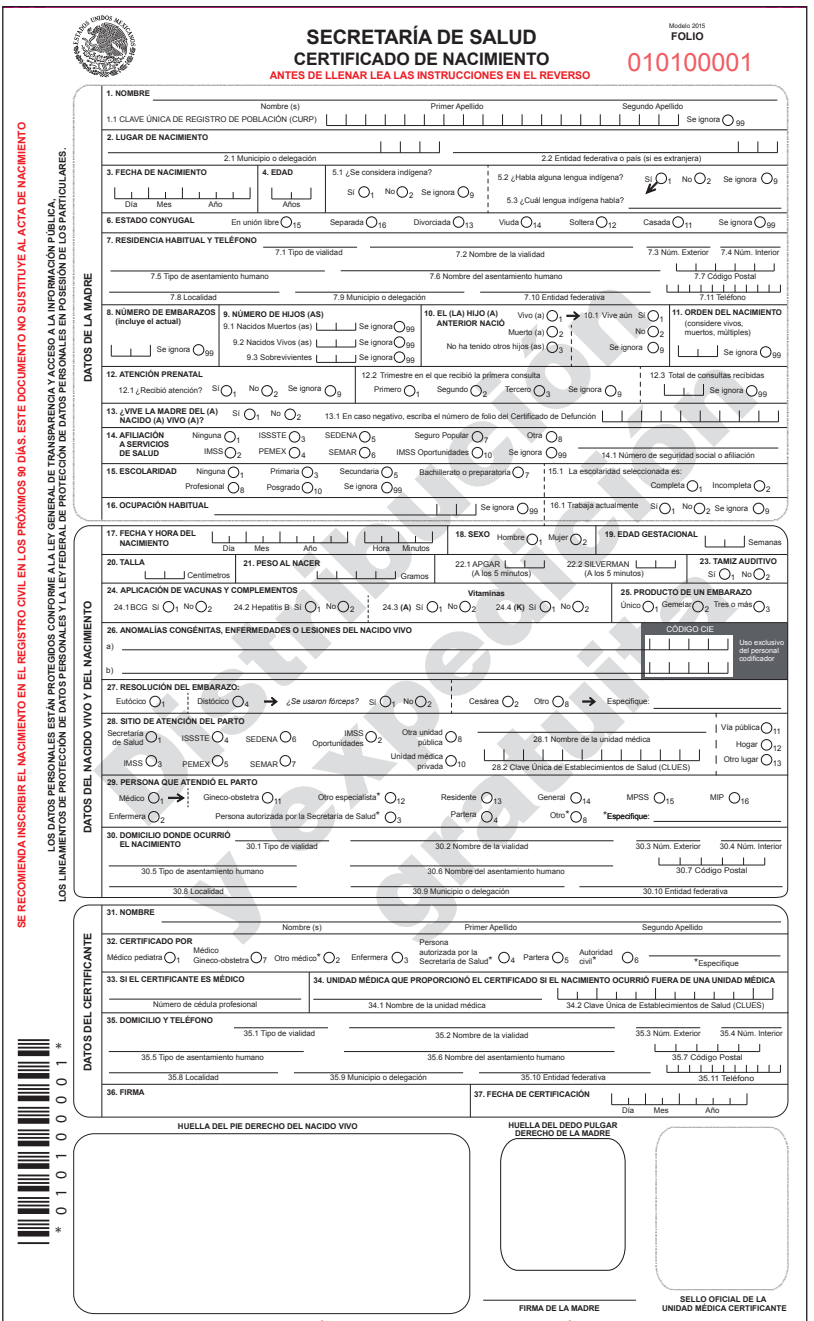
que éste proceda a boletinar en sus Oficialías los folios de los Certificados de Nacimiento robados y/o extraviados.

IV. Por último, los SESA deben enviar a la DGIS vía correo electrónico una copia del oficio entregado al Registro Civil Estatal para que esta Dirección General realice la notificación al RENAPO, institución que procederá a informar a los Registros Civiles a nivel nacional para evitar el mal uso de los Certificados robados o extraviados.

- En caso de que la madre extravíe el Certificado de Nacimiento y éste haya sido expedido en una unidad médica. La madre debe acudir a la autoridad competente (Ministerio Público, Juez de lo Civil, Jefe Municipal, Comisariado Ejidal, etc.) para solicitar una constancia de hechos, con este documento debe presentarse en la unidad médica que le proporcionó el Certificado original, para que ésta le entregue una copia fotostática, debidamente sellada y firmada por el Director de la unidad médica o en su defecto por el área o persona que este último designe (como por ejemplo, el área jurídica de la unidad).
- En caso de que la madre extravíe el Certificado de Nacimiento y éste haya sido expedido fuera de una unidad médica por una persona autorizada por la Secretaría de Salud, la madre debe presentar la constancia de hechos a la instancia responsable de la distribución de dicho Certificado (Jurisdicción Sanitaria, unidad médica, área específica designada por cada institución o los Servicios Estatales de Salud) para que en ésta le entreguen una copia fotostática, debidamente sellada y firmada por la persona responsable. En estos casos es importante que el certificante oriente a los familiares sobre el lugar al que les corresponde acudir para solicitar dicha copia.
- En caso de que el Certificado de Nacimiento haya sido extraviado o robado a la madre, ésta debe acudir al Ministerio Público correspondiente para presentar una denuncia de hechos y seguir el procedimiento mencionado en los puntos anteriores.

VI. Formato del Certificado de Nacimiento.

Anverso



SECRETARÍA DE SALUD
CERTIFICADO DE NACIMIENTO
ANTES DE LLENAR LEA LAS INSTRUCCIONES EN EL REVERSO

Modelo 2015
FOLIO
010100001

SE RECOMIENDA INSCRIBIR EL NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL EN LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS. ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE AL ACTA DE NACIMIENTO

LOS DATOS PERSONALES ESTÁN PROTEGIDOS CONFORME A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

DATOS DE LA MADRE

1. NOMBRE (Nombre (s) / Primer Apellido / Segundo Apellido)
1.1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) — Se ignora 99
2. LUGAR DE NACIMIENTO
2.1 Municipio o delegación — 2.2 Entidad federativa o país (si es extranjera)
3. FECHA DE NACIMIENTO (Día / Mes / Año)
4. EDAD (Años)
5.1 ¿Se considera indígena? Sí 1 No 2 Se ignora 9
5.2 ¿Habla alguna lengua indígena? Sí 1 No 2 Se ignora 9
5.3 ¿Cuál lengua indígena habla?
6. ESTADO CONYUGAL — En unión libre 15 | Separada 16 | Divorciada 13 | Viuda 14 | Soltera 12 | Casada 11 | Se ignora 99
7. RESIDENCIA HABITUAL Y TELÉFONO
7.1 Tipo de vialidad — 7.2 Nombre de la vialidad — 7.3 Núm. Exterior — 7.4 Núm. Interior
7.5 Tipo de asentamiento humano — 7.6 Nombre del asentamiento humano — 7.7 Código Postal
7.8 Localidad — 7.9 Municipio o delegación — 7.10 Entidad federativa — 7.11 Teléfono
8. NÚMERO DE EMBARAZOS (incluye el actual) — Se ignora 99
9. NÚMERO DE HIJOS (AS)
9.1 Nacidos Muertos (as) — Se ignora 99
9.2 Nacidos Vivos (as) — Se ignora 99
9.3 Sobrevivientes — Se ignora 99
10. EL (LA) HIJO (A) ANTERIOR NACIÓ — Vivo (a) 1 → 10.1 Vive aún Sí 1 / No 2 / Se ignora 9 — Muerto (a) 2 — No ha tenido otros hijos (as) 3
11. ORDEN DEL NACIMIENTO (considere vivos, muertos, múltiples) — Se ignora 99
12. ATENCIÓN PRENATAL
12.1 ¿Recibió atención? Sí 1 No 2 Se ignora 9
12.2 Trimestre en el que recibió la primera consulta — Primero 1 | Segundo 2 | Tercero 3 | Se ignora 9
12.3 Total de consultas recibidas — Se ignora 99
13. ¿VIVE LA MADRE DEL (A) NACIDO (A) VIVO (A)? Sí 1 No 2
13.1 En caso negativo, escriba el número de folio del Certificado de Defunción
14. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD — Ninguna 1 | ISSSTE 3 | SEDENA 5 | Seguro Popular 7 | Otra 8 | IMSS 2 | PEMEX 4 | SEMAR 6 | IMSS Oportunidades 10 | Se ignora 99
14.1 Número de seguridad social o afiliación
15. ESCOLARIDAD — Ninguna 1 | Primaria 3 | Secundaria 5 | Bachillerato o preparatoria 7 | Profesional 8 | Posgrado 10 | Se ignora 99
15.1 La escolaridad seleccionada es: Completa 1 | Incompleta 2
16. OCUPACIÓN HABITUAL — Se ignora 99
16.1 Trabaja actualmente Sí 1 No 2 Se ignora 9

DATOS DEL NACIDO VIVO Y DEL NACIMIENTO

17. FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO (Día / Mes / Año / Hora / Minutos)
18. SEXO Hombre 1 Mujer 2
19. EDAD GESTACIONAL — Semanas
20. TALLA — Centímetros
21. PESO AL NACER — Gramos
22.1 APGAR (A los 5 minutos)
22.2 SILVERMAN (A los 5 minutos)
23. TAMIZ AUDITIVO Sí 1 No 2
24. APLICACIÓN DE VACUNAS Y COMPLEMENTOS
24.1 BCG Sí 1 No 2 — 24.2 Hepatitis B Sí 1 No 2
Vitaminas: 24.3 (A) Sí 1 No 2 — 24.4 (K) Sí 1 No 2
25. PRODUCTO DE UN EMBARAZO — Único 1 | Gemelar 2 | Tres o más 3
26. ANOMALÍAS CONGÉNITAS, ENFERMEDADES O LESIONES DEL NACIDO VIVO
a)
b)
CÓDIGO CIE — Uso exclusivo del personal codificador
27. RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO: Eutócico 1 | Distócico 4 → ¿Se usaron fórceps? Sí 1 No 2 | Cesárea 2 | Otro 8 → Especifique:
28. SITIO DE ATENCIÓN DEL PARTO — Secretaría de Salud 1 | ISSSTE 4 | SEDENA 6 | IMSS Oportunidades 2 | Otra unidad pública 8 | Unidad médica privada 10 | IMSS 3 | PEMEX 5 | SEMAR 7
28.1 Nombre de la unidad médica
28.2 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
Vía pública 11 | Hogar 12 | Otro lugar 13
29. PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO — Médico 1 → Gineco-obstetra 11 | Otro especialista* 12 | Residente 13 | General 14 | MPSS 15 | MIP 16 | Enfermera 2 | Persona autorizada por la Secretaría de Salud* 3 | Partera 4 | Otro* 8 | *Especifique:
30. DOMICILIO DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO
30.1 Tipo de vialidad — 30.2 Nombre de la vialidad — 30.3 Núm. Exterior — 30.4 Núm. Interior
30.5 Tipo de asentamiento humano — 30.6 Nombre del asentamiento humano — 30.7 Código Postal
30.8 Localidad — 30.9 Municipio o delegación — 30.10 Entidad federativa

DATOS DEL CERTIFICANTE

31. NOMBRE (Nombre (s) / Primer Apellido / Segundo Apellido)
32. CERTIFICADO POR — Médico pediatra 1 | Médico Gineco-obstetra 7 | Otro médico* 2 | Enfermera 3 | Persona autorizada por la Secretaría de Salud* 4 | Partera 5 | Autoridad civil* 6 | *Especifique
33. SI EL CERTIFICANTE ES MÉDICO — Número de cédula profesional
34. UNIDAD MÉDICA QUE PROPORCIONÓ EL CERTIFICADO SI EL NACIMIENTO OCURRIÓ FUERA DE UNA UNIDAD MÉDICA
34.1 Nombre de la unidad médica — 34.2 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
35. DOMICILIO Y TELÉFONO
35.1 Tipo de vialidad — 35.2 Nombre de la vialidad — 35.3 Núm. Exterior — 35.4 Núm. Interior
35.5 Tipo de asentamiento humano — 35.6 Nombre del asentamiento humano — 35.7 Código Postal
35.8 Localidad — 35.9 Municipio o delegación — 35.10 Entidad federativa — 35.11 Teléfono
36. FIRMA
37. FECHA DE CERTIFICACIÓN (Día / Mes / Año)

HUELLA DEL PIE DERECHO DEL NACIDO VIVO
HUELLA DEL DEDO PULGAR DERECHO DE LA MADRE
FIRMA DE LA MADRE
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD MÉDICA CERTIFICANTE

ENTREGAR A LA MADRE PARA EL TRÁMITE DEL ACTA DE NACIMIENTO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

0101000001

Ejemplo sin valor oficial

Reverso

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO

NACIDO VIVO: PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN QUE FUE EXPULSADO O EXTRAÍDO COMPLETO DEL CUERPO DE LA MADRE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DURACIÓN DEL EMBARAZO Y QUE DESPUÉS DE ESTA SEPARACIÓN RESPIRA O MANIFIESTA CUALQUIER OTRO SIGNO DE VIDA COMO LATIDOS DEL CORAZÓN, PULSACIONES DEL CORDÓN UMBILICAL O MOVIMIENTOS EFECTIVOS DE LOS MÚSCULOS DE CONTRACCIÓN VOLUNTARIA, TANTO SI SE HA CORTADO O NO EL CORDÓN UMBILICAL Y ESTÉ O NO DESPRENDIDA LA PLACENTA. (CIE-10, VOLUMEN 2).

INSTRUCCIONES GENERALES:

- **El Certificado de Nacimiento debe llenarse en las primeras veinticuatro horas posteriores al nacimiento, una vez corroborado el hecho y el vínculo madre-hijo(a).**
- **Para la expedición del Certificado de Nacimiento es indispensable solicitar la identificación oficial de la madre (que preferentemente contenga su domicilio).**
- **El Certificado de Nacimiento debe ser expedido por única vez a todo nacido vivo en territorio nacional, en forma gratuita y obligatoria, por la persona que atendió al nacido vivo después del parto; cuando esto no sea posible, debe ser llenado por la persona autorizada para ello por la autoridad sanitaria competente.**
- **Llene un Certificado de Nacimiento por cada producto nacido vivo, elabore tantos certificados como productos nacidos vivos resulten del nacimiento.**
- **Una vez expedido, la entrega de este certificado no debe ser condicionada bajo ninguna circunstancia.**
- **Este certificado debe llenarse en original y dos copias, entregándose el original a la madre con la instrucción de llevarlo lo antes posible al Registro Civil para tramitar la correspondiente Acta de Nacimiento.**
- **Si el nacimiento ocurre en una unidad médica consulte la historia clínica de la madre y su documento de identificación para el correcto llenado de este certificado, en caso contrario auxíliese con la información proporcionada por la madre, el padre o algún familiar.**
- **Escriba con tinta (no utilice pluma de gel), usando letra de molde clara y legible o con máquina de escribir. No use abreviaturas.**
- **Escriba sobre una superficie plana y firme, presionando al escribir para legibilidad de las copias.**
- **Este documento no es válido con tachaduras o enmendaduras; para realizar correcciones debe utilizarse el espacio de "FE DE ERRATAS", cuyas instrucciones y exclusiones deben consultarse en el Manual del Llenado del Certificado de Nacimiento.**
- **Marque con una "X", sobre el circulo correspondiente a la respuesta. Marque una sola opción, excepto la pregunta número 14.**
- **Sólo cuando se desconozca la información y después de agotar todos los recursos para obtenerla: Si existe una opción "Se Ignora" márquela con una "X", en el caso de casillas llene con "nueves" y en el caso de respuestas abiertas anote "Se ignora".**
- **Para las respuestas numéricas (fecha, gramos, horas, edad) use números arábigos (0,1,2,...,9) y complete con ceros a la izquierda en caso de tener espacios vacíos.**
- **En los campos de fecha debe utilizarse el formato ¡DD¡MM¡AAAA¡, completando con cero a la izquierda para los días y meses de un dígito (ej. para el 06 de mayo de 2014) anote ¡06¡05¡2014¡.**
- **Para las preguntas con opciones que tengan * (asterisco) se debe especificar en el espacio asignado para tal fin.**
- **Para los domicilios anote: tipo de vialidad (ej. Calle, Avenida, Camino, Carretera, Diagonal, Calzada, Peatonal, Boulevard), Nombre de la vialidad, Núm. Exterior (ej. 980) e interior si aplica (21, 2A, G5), Tipo de asentamiento humano (ej. Colonia, Fraccionamiento, Puerto, Ejido, Ranchería, Pueblo, Unidad Habitacional), Nombre del asentamiento, Código Postal, localidad, municipio o delegación y entidad federativa. Evite anotar "domicilio conocido".**
- **Imprima en el espacio correspondiente (original y copias) la huella del pie derecho del nacido vivo y la huella del pulgar derecho de la madre; en caso de no contar con el miembro derecho registre la huella del pulgar izquierdo.**
- **Para más detalles del llenado de este formato, excepciones y particularidades, consulte el Manual del Llenado del Certificado de Nacimiento.**

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

1) **NOMBRE. Anote el nombre completo de la madre sin abreviaturas, iniciando por el(los) nombre(s), seguido del primer y segundo apellido, tal cual aparezca en su identificación oficial. En la pregunta 1.1 CURP agote los recursos disponibles para obtenerla.**
2) **LUGAR DE NACIMIENTO. Anote el nombre del municipio o delegación y de la entidad federativa donde nació la madre. Si ésta nació en el extranjero, deje en blanco la pregunta municipio o delegación y anote el nombre del país en el espacio para la "Entidad federativa".**
4) **EDAD. Registre la edad cumplida en años de la madre. Revise la concordancia de la fecha de nacimiento de la madre y la fecha de nacimiento del nacido vivo.**
5) **En 5.1 marque si la madre se considera o no indígena. En 5.2 indique si la madre habla alguna lengua indígena y en caso afirmativo especifique en 5.3 la lengua.**
7) **RESIDENCIA HABITUAL Y TELÉFONO. Anote la dirección de la vivienda donde reside habitualmente la madre y el teléfono donde se le pueda localizar. Si la residencia habitual corresponde a un país diferente a México, anote en el espacio de "Entidad federativa" el nombre de éste.**
8) **NÚMERO DE EMBARAZOS. Anote el total de embarazos que ha tenido la mujer a lo largo de su vida sin importar el término de los mismos, es decir: nacidos vivos, nacidos muertos (sin importar las semanas de gestación, incluyendo abortos), molas y embarazos ectópicos. Además debe incluir este último embarazo.**
9) **NÚMERO DE HIJOS(AS). Anote en 9.1 el total de hijos(as) nacidos muertos(as) (sin importar las semanas de gestación, incluyendo abortos), molas y embarazos ectópicos, si la mujer no ha tenido hijos(as) nacidos muertos(as), anote ¡0¡0¡. Escriba en 9.2 el total de hijos(as) nacidos vivos(as) que ha tenido la madre, incluyendo al que se está certificando, sin importar que alguno de éstos después fallecieran. En 9.3 anote cuantos de los hijos(as) registrados en 9.2 Sobrevivientes, incluyendo al nacido vivo(a) que se está certificando.**
10) **EL(LA) HIJO(A) ANTERIOR NACIÓ. Si éste es el primer hijo(a) marque "No ha tenido otros hijos(as)". Independientemente si se trata de un embarazo múltiple: Si el hijo(a) anterior nació vivo(a) marque la opción "vivo(a)" y en 10.1 anote si éste vive o no. Si el hijo(a) anterior nació muerto(a) marque la opción "muerto(a)" y omita la respuesta de 10.1.**
11) **ORDEN DEL NACIMIENTO. Escriba el orden numérico que ocupa el nacido vivo que se certifica, considerándolo como el último del total de nacimientos que a esta fecha haya tenido la madre, tomando en cuenta tanto a los nacidos vivos como a los nacidos muertos, independientemente de que a la fecha estén vivos o no. Para el caso de un parto múltiple, considere el orden que corresponda a cada producto.**
12) **ATENCIÓN PRENATAL. 12.1 Marque si recibió o no atención prenatal por un profesional de la salud durante el embarazo, en caso afirmativo anote en 12.2 el trimestre de la gestación en que recibió la primera consulta y en 12.3 el total de consultas recibidas durante todo el embarazo.**
13) **¿VIVE LA MADRE DEL NACIDO(A) VIVO(A)?. Seleccione "No", si la madre falleció antes de la expedición de este certificado, en este caso debe anotar en 13.1, el número de folio del Certificado de Defunción de la madre.**
14) **AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. Marque la afiliación o derechohabiencia de la madre. La opción "Ninguna" debe seleccionarse cuando la madre haya manifestado no tener afiliación a servicios de salud, en este caso omitir la respuesta en 14.1. Una persona puede tener más de una afiliación o derechohabiencia, por lo que es importante leer todas las opciones y marcar las señaladas por la madre (admite hasta dos respuestas). Cuando la madre tenga al menos una afiliación o derechohabiencia, anotar en 14.1 el número de seguridad social o afiliación correspondiente. Para el caso de más de una afiliación o derechohabiencia consultar el Manual del Llenado del Certificado de Nacimiento.**
15) **ESCOLARIDAD. Si la madre no tiene escolaridad marque la casilla de "Ninguna"; en caso contrario anote la opción que indique el nivel máximo de estudios y en 15.1 indique si la escolaridad seleccionada en 15 es completa o incompleta.**
16) **OCUPACIÓN HABITUAL. Anote la ocupación principal de la madre (ej. enfermera, secretaria, mesera, maestra). En 16.1 marque la opción "Si" cuando la madre cuente con un trabajo remunerado, labore en un negocio familiar o por su cuenta, independientemente de que perciba o no ingresos. Marque "No" cuando la madre se dedique a los quehaceres del hogar, cuidados de los hijos, a estudiar, sea rentista, jubilada, etc.**
17) **FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO. Anote el día, mes, año y hora de ocurrencia del nacimiento que se está certificando. Registre la hora en el formato ¡H1H2¡M1M2¡ usando la escala de 24 horas. (ej. Si el nacimiento ocurrió a las doce de la noche con 5 minutos anote ¡1¡0¡0¡5¡).**
18) **SEXO. Si no es posible definir el sexo del nacido vivo, omita la respuesta y asegúrese de anotar la(s) afección(es) en la variable 26.**
19) **EDAD GESTACIONAL. Anote la duración del embarazo en semanas completas obtenidas mediante la valoración por Capurro, si esto no es posible calcule contando a partir del primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha de ocurrencia del nacimiento.**
21) **PESO AL NACER. Anote el peso del nacido vivo expresado en gramos (ej. Si el nacido vivo pesa 2 kilos 350 gramos anote ¡2¡3¡5¡0¡ Gramos).**
25) **PRODUCTO DE UN EMBARAZO. Marque la opción que corresponda al número total de productos (nacidos vivos o muertos) de este parto. Si el embarazo es múltiple se debe expedir un Certificado de Nacimiento para cada producto nacido vivo, respetando el orden de acuerdo a la hora de nacimiento.**
26) **ANOMALÍAS CONGÉNITAS, ENFERMEDADES O LESIONES DEL NACIDO VIVO. Si el nacido vivo presenta anomalías congénitas, enfermedades o lesiones originadas en el periodo perinatal, anótelas en el espacio correspondiente. En caso de no presentar patologías, se debe especificar anotando la frase "Ninguna aparente". Deje en blanco el recuadro sombreado en gris para "Uso exclusivo del personal codificador", quien anotará el código de la CIE vigente que corresponda.**
27) **RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO. Seleccione la opción que corresponda a la resolución utilizada para atender el nacimiento: eutócico, distócico (para éste además marque si se usaron fórceps o no), cesárea u otro (en éste último caso especificar en el espacio contiguo).**
29) **PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO. Si el parto fue atendido por un médico, marque la opción "Médico" y enseguida seleccione el tipo de médico (Gineco-obstetra, Otro especialista, Residente, General, Médico Pasante en Servicio Social -MPSS- o Médico Interno de Pregrado -MIP-), en caso contrario marque de entre el resto de las opciones la adecuada. Cuando aplique (opciones con *) especifique en el espacio asignado para tal fin.**
32) **CERTIFICADO POR. Marcar la opción que identifica a la persona responsable de la certificación del nacimiento. Si el certificado es llenado por un Médico Pasante en Servicio Social, seleccionar la opción "Persona autorizada por la Secretaría de Salud" y anotar "Médico Pasante" en el espacio para especificar. Cuando aplique (opciones con *) especifique en el espacio asignado para tal fin.**
34) **UNIDAD MÉDICA QUE PROPORCIONÓ EL CERTIFICADO SI EL NACIMIENTO OCURRIÓ FUERA DE UNA UNIDAD MÉDICA. Esta pregunta debe responderse cuando el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica y la persona que asistió el parto no está autorizada para emitir certificados, en este caso indique en 34.1 el nombre de la unidad médica que proporcionó el formato del certificado y en 34.2 la CLUES correspondiente.**

FE DE ERRATAS
En esta sección no es válido corregir el nombre completo de la madre: nombre(s) y apellidos.

Sello oficial de la Unidad Médica

1) Núm. de pregunta: ____ **Corrección:** _____

2) Núm. de pregunta: ____ **Corrección:** _____

3) Núm. de pregunta: ____ **Corrección:** _____

Responsable de la corrección:

Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Firma

Representación impresa de la versión electrónica del Certificado de Nacimiento



SECRETARÍA DE SALUD

REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL
CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE NACIMIENTO

MODELO 2015
FOLIO

SE RECOMIENDA INSCRIBIR EL NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS, ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE AL ACTA DE NACIMIENTO

DATOS DE LA MADRE

1. NOMBRE(S): PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:
1.1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP):
2. LUGAR DE NACIMIENTO 2.1 Municipio/Delegación: 2.2 Entidad federativa/país (si es extranjera):
3. FECHA DE NACIMIENTO: 4. EDAD: 5.1 ¿Se considera indígena? 5.2 ¿Habla alguna lengua indígena? 5.3 ¿Cuál lengua indígena habla?
6. ESTADO CONYUGAL:
7. RESIDENCIA HABITUAL Y TELÉFONO 7.1 Tipo de vialidad: 7.2 Nombre de la vialidad:
7.3 Núm. Exterior: 7.4 Núm. Interior: 7.5 Tipo de asentamiento humano:
7.6 Nombre del asentamiento humano: 7.7 Código Postal:
7.8 Localidad: 7.9 Municipio o delegación: 7.10 Entidad federativa: 7.11 Teléfono:
8. NO. DE EMBARAZOS (incluye el actual): 9. NO. DE HIJO(A)(S): 9.1 Nacidos muertos(as): 9.2 Nacidos vivos(as): 9.3 Sobrevivientes:
10. EL(LA) HIJO(A) ANTERIOR NACIÓ: 10.1 Vivo aún: 11. ORDEN DEL NACIMIENTO (vivos, muertos y múltiples):
12. ATENCIÓN PRENATAL 12.1 ¿Recibió atención? 12.2 Trimestre en el que recibió la primera consulta: 12.3 Total de consultas recibidas:
13. ¿VIVE LA MADRE DEL(LA) NACIDO(A) VIVO(A)? 13.1 En caso negativo, escriba el número de folio del Certificado de Defunción:
14. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD: 14.1 Número de seguridad social o afiliación:
15. ESCOLARIDAD: 15.1 La escolaridad seleccionada es:
16. OCUPACIÓN HABITUAL: 16.1 Trabaja actualmente:

DATOS NACIDO VIVO Y NACIMIENTO

17. FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO: FECHA: HORA: 18. SEXO: 19. EDAD GESTACIONAL:
20. TALLA: 21. PESO AL NACER: 22.1 APGAR: 22.2 SILVERMAN: 23. TAMIZ AUDITIVO:
24. APLICACIÓN DE VACUNAS Y COMPLEMENTOS 24.1 BCG: 24.2 Hepatitis B: 24.3 Vitamina A: 24.4 Vitamina K:
25. PRODUCTO DE UN EMBARAZO:
26. ANOMALÍAS CONGÉNITAS, ENFERMEDADES O LESIONES DEL NACIDO VIVO
a)
b)
27. RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO: Si la resolución del embarazo fue distocia, ¿Se aplicó fórceps? Si la resolución fue "Otra", especifique:
28. SITIO DE ATENCIÓN DEL PARTO: 28.1 Nombre de la unidad médica: 28.2 CLUES:
29. PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO: Si fue "Otra", especifique:
30. DOMICILIO DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO 30.1 Tipo de vialidad: 30.2 Nombre de la vialidad:
30.3 Núm. Exterior: 30.4 Núm. Interior: 30.5 Tipo de asentamiento humano:
30.6 Nombre del asentamiento humano: 30.7 Código Postal:
30.8 Localidad: 30.9 Municipio o delegación: 30.10 Entidad federativa:

DATOS CERTIFICANTE

31. NOMBRE(S): PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:
32. CERTIFICADO POR: Si es el caso, especifique:
33. SI EL CERTIFICANTE ES MÉDICO: Número de cédula profesional:
34. UNIDAD MÉDICA QUE PROPORCIONA EL CERTIFICADO SI EL NACIMIENTO OCURRIÓ FUERA DE UNA UNIDAD MÉDICA
34.1 Nombre de la unidad médica: 34.2 CLUES:
35. DOMICILIO Y TELÉFONO 35.1 Tipo de vialidad: 35.2 Nombre de la vialidad:
35.3 Núm. Exterior: 35.4 Núm. Interior: 35.5 Tipo de asentamiento humano:
35.6 Nombre del asentamiento humano: 35.7 Código Postal:
35.8 Localidad: 35.9 Municipio o delegación: 35.10 Entidad federativa: 35.11 Teléfono:

HUELLA DEL PIE DERECHO DEL NACIDO VIVO

HUELLA DACTILAR DE LA MADRE

CÓDIGO QR

FIRMA DE LA MADRE

36. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL CERTIFICANTE

CADENA ORIGINAL

SELLO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y UNIDAD MÉDICA

LOS DATOS PERSONALES ESTÁN PROTEGIDOS CONFORME A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

ENTREGAR A LA MADRE PARA QUE SOLICITE EL ACTA DE NACIMIENTO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

LA FALSIFICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SERÁ VERIFICADA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA TAL FIN POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

ENTREGAR A LA MADRE PARA EL TRÁMITE DEL ACTA DE NACIMIENTO EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL

EXPEDICIÓN GRATUITA

VII. Descripción del Certificado de Nacimiento

El Certificado de Nacimiento está dividido en 6 secciones:

1. Datos de la madre
2. Datos del nacido vivo y del nacimiento
3. Datos del certificante
4. Otros métodos de identificación
5. Instrucciones de llenado generales y específicas
6. Fe de erratas

1. Datos de la madre (preguntas 1 a la 16).

El objetivo de este apartado es obtener información sociodemográfica de la madre, de su historial reproductivo, así como de si ésta vive al momento en que se expide el Certificado de Nacimiento:

- Nombre Completo
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Lugar de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Condición étnica
- Estado conyugal
- Residencia habitual
- Número de embarazos
- Número de hijos(as) nacidos(as) muertos(as)
- Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) y sobrevivientes
- Supervivencia del hijo(a) previo(a)
- Orden del nacimiento
- Atención prenatal
- Trimestre en el que recibió la primer consulta de atención prenatal
- Total de consultas de atención prenatal recibidas
- ¿Vive la madre del nacido (a) vivo(a)?
- Afiliación a los servicios de salud

- Número de seguridad social o afiliación
- Escolaridad
- Ocupación habitual
- Situación laboral actual

2. Datos del nacido vivo y del nacimiento (preguntas 17 a la 30).

El objetivo de este apartado es obtener información sobre las características del nacido vivo, incluyendo la medición de las condiciones generales y su función respiratoria al momento del nacimiento, la aplicación de vacunas, complementos, así como de las características mismas del nacimiento, el lugar y la persona que lo atendió:

- Fecha y hora de nacimiento
- Sexo
- Edad gestacional
- Talla al nacer
- Peso al nacer
- Valoración de APGAR y Silverman
- Tamiz auditivo
- Aplicación de vacunas y complementos
- Producto de un embarazo
- Anomalías congénitas, enfermedades o lesiones
- Resolución del embarazo
- Sitio de atención
- Persona que atendió
- Domicilio del sitio de atención donde ocurrió el nacimiento

3. Datos del certificante (pregunta 31 a la 37).

En este apartado se captan los datos de identificación de la persona que expidió el Certificado de Nacimiento incluyendo, para el caso de los médicos, la cédula profesional. Los datos que se solicitan son de suma importancia para realizar cualquier aclaración posterior:

- Nombre
- Certificado por (Médico Pediatra, Médico gineco-obstetra, Otro Médico, Enfermera, Persona autorizada por la Secretaría

de Salud o Partera)
- Si el certificante es médico, anotar su cedula profesional (aplica a los médicos certificantes)
- Unidad médica donde se certifica, en caso de que el nacimiento haya ocurrido fuera de una unidad médica
- Domicilio y teléfono
- Firma
- Fecha de certificación

4. Otros métodos de identificación de la madre, el nacido vivo y de la unidad médica.

Incluye la captación de elementos de identificación del nacido vivo, de la madre y el sello oficial de la unidad médica que avala la certificación:

- Huella del pie derecho del nacido vivo
- Huella del dedo pulgar derecho de la madre
- Firma de la madre
- Sello oficial de la unidad médica que certificó

5. Instrucciones de llenado generales y específicas.

Este apartado contiene la definición de nacido vivo y una selección de las principales instrucciones generales y específicas, cuyo fin es coadyuvar al correcto llenado del Certificado de Nacimiento. Para más detalles consultar el glosario de terminos.

6. Fe de erratas.

Se localiza en la parte inferior del reverso del formato del Certificado de Nacimiento, en este apartado se podrán realizar correcciones (máximo 3) a la información anotada en los tres primeros apartados del Certificado y con ello evitar, cuando sea posible, la cancelación del formato por error de llenado. También se debe especificar el nombre de quien realiza la corrección. Esta sección no aplica para la representación impresa de la versión electrónica del Certificado de Nacimiento.

VIII. Llenado del Certificado de Nacimiento

Consideraciones previas al llenado

- La persona que expide el Certificado debe llenarlo en su totalidad, exceptuando aquellas preguntas que no apliquen. Para las preguntas cuya respuesta se desconoce al momento de llenar el Certificado, debe seleccionarse la opción 'Se ignora'.

- Para que un Certificado sea considerado válido debe incluir la firma del certificante, la firma de la madre, la huella del pie derecho del nacido vivo, la huella del pulgar derecho de la madre (para lo cual no se requiere de una tinta especial) y en caso de que haya sido expedido en una unidad médica, el sello de la misma. Si el Certificado se expidió fuera de una unidad médica no será necesario el sello de la institución. Si la madre no sabe leer ni escribir, el formato deberá llevar forzosamente la huella del pulgar derecho de la madre, tanto en el espacio destinado para ello, como en el espacio para que ésta plasme su firma. Para las huellas (tanto del nacido vivo como de la madre), en caso de no contar con la extremidad derecha registre la correspondiente de la extremidad izquierda y cuando carezca de ambas colocar una 'X'.

- Previo a la firma de la madre, ésta debe revisar el contenido del Certificado y manifestar su conformidad con la información anotada. Cuando la madre no sepa leer y escribir, el certificante debe dar lectura completa del Certificado, a fin de que ella conozca y apruebe la información registrada en el mismo.

- En caso de que se cometa alguna equivocación al llenar el Certificado de Nacimiento, no deben hacerse tachaduras ni enmendaduras, ya que ello invalida el documento; para estos casos, debe utilizarse el apartado de la 'Fe de Erratas', tomando en cuenta tanto las limitaciones que este apartado tiene, como las instrucciones para su uso. Si el total de errores rebasa el alcance de la 'Fe de Erratas'

se debe proceder a cancelar el Certificado y elaborar uno nuevo, sin importar el tiempo transcurrido de la expedición con errores. Esta sección no aplica para la representación impresa de la versión electrónica del Certificado de Nacimiento, para este se debe cancelar y expedir uno nuevo.

- En las preguntas de opción múltiple, el certificante debe seleccionar sólo una opción, excepto en la pregunta 14 'Afiliación a Servicios de Salud', donde podrá elegir máximo dos opciones. En las preguntas abiertas debe escribir la información proporcionada por las fuentes respectivas, para las respuestas en que se requiera anotar números (fecha, gramos, horas, edad, etc.) deben usarse números arábigos (0, 1, 2, ... , 9) y donde haya casillas debe anotarse un dígito por cada una de ellas.

- La persona que llene y firme el Certificado de Nacimiento es la única responsable de su contenido, por lo que se recomienda llenarlo cuidadosamente, plasmando información completa y veraz; de lo contrario deberá sujetarse a las implicaciones jurídicas que pudieran sucederse.

- Es responsabilidad del certificante que la información vertida en el Certificado sea clara y legible, tanto en el original como en las dos copias. Por lo que en caso de llenar el Certificado a mano, deberá escribir con tinta, utilizando letra de molde, no usar abreviaturas (excepto las señaladas en las instrucciones específicas de cada pregunta), utilizar únicamente BOLÍGRAFO, no usar plumas con tinta de gel, pluma fuente, plumón o similares, debido a que los trazos pierden claridad y este tipo de tintas tienden a desaparecer con el tiempo. Se debe oprimir el bolígrafo lo suficiente para garantizar la legibilidad en las copias y apoyarse en una superficie plana y firme.

- El certificante debe advertir a la madre que los datos personales contenidos en el Certificado, como lo son: su nombre, su fecha y lugar de nacimiento, así como su estado conyugal es información que se verificará en el Registro Civil para expedir el Acta de Nacimiento del nacido vivo, por lo que es muy importante que estos datos sean veraces.

- El certificante debe informar a la madre sobre la importancia de proporcionar su residencia habitual correcta, ya que de ello dependerá el seguimiento oportuno que pueda recibir su hijo(a) para completar su esquema de vacunación y con ello evitar la presencia posterior de enfermedades prevenibles.

- Por ningún motivo se debe comercializar el Certificado de Nacimiento ni condicionar su entrega. La contravención a lo dispuesto en este lineamiento será sancionado conforme a las penas a que se hagan acreedores de conformidad a lo establecido en la legislación penal vigente de cada entidad federativa, y tratándose de servidores públicos, además a lo señalado en las Leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos que correspondan.

- En el caso extraordinario de que el nacido vivo se encuentre en situación de desamparo, el Certificado de Nacimiento debe ser entregado a la instancia que haya asumido la responsabilidad del nacido vivo. Si además, se desconozcan los datos de la madre y/o las circunstancias de su nacimiento, las respuestas a las preguntas del apartado 'DATOS DE LA MADRE' podrán elegirse como ignoradas, de la misma forma que podrán omitirse los elementos para su identificación (huella y firma); en el apartado 'DATOS DEL NACIDO VIVO Y DEL NACIMIENTO' podrán dejarse en blanco las preguntas cuya respuesta se desconozca.

Instrucciones específicas del llenado de cada pregunta.

1. Datos de la madre

Para el llenado de este apartado, debe consultarse la historia clínica de la madre y sus documentos de identificación. De no existir la historia clínica auxíliese de la información proporcionada por la madre y en caso de complicación, discapacidad o fallecimiento de ésta acuda al padre del nacido vivo o a los familiares (de preferencia directos).

1. Nombre

Anotar el nombre completo de la madre, iniciando por el(los) nombre(s), seguido de los apellidos.

- El nombre de la madre debe anotarse exactamente igual a lo asentado en el Acta de Nacimiento, por lo que se recomienda copiarlo directamente de este documento o en su defecto, de la identificación oficial o comprobante de identidad que presente la madre.

- No utilizar abreviaturas, a menos que se encuentre la información de esa manera en el Acta de Nacimiento, en la identificación oficial o en el comprobante de identidad que presente la madre.

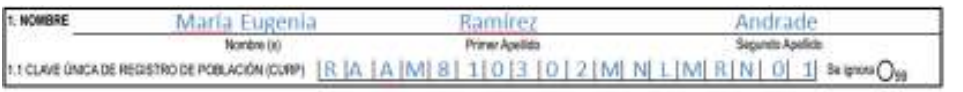
- Cabe resaltar que el Acta de Nacimiento de la madre no es un requisito para la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento, sin embargo, si la madre la presenta, se le dará preferencia para la inscripción de su nombre.

1.1 CURP. Se debe anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la madre en los espacios correspondientes. Esta información es de vital importancia.

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Para obtener la CURP de la madre debe agotar todas las

opciones posibles (consultar en la credencial de elector, en el expediente clínico, en su credencial de afiliación a los servicios de salud, entre otras) y como último recurso debe acceder a la siguiente página web para obtenerla:
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

- En caso de desconocer esta información, elegir la opción 'Se ignora', dejando en blanco los espacios para anotar la CURP.



2. Lugar de nacimiento

Registrar la ubicación del lugar donde la madre del nacido vivo haya nacido.

2.1 Municipio o Delegación. Anotar dentro del espacio correspondiente el municipio o delegación (para el Distrito Federal), en donde haya nacido la madre.

- Si la madre es extranjera se debe dejar en blanco.
- En caso de que esta información se desconozca, escribir la leyenda **"Se ignora".**

2.2 Entidad federativa o país. Anotar dentro del espacio correspondiente la entidad federativa en donde haya nacido la madre.

- Si la madre es extranjera se debe anotar el país de nacimiento. Ejemplo: Estados Unidos de América, Guatemala, Nicaragua, España, entre otros.
- En caso de que esta información se desconozca, escribir la leyenda **"Se ignora"**.



3. FECHA DE NACIMIENTO

Anotar el día, mes y año de nacimiento de la madre.

- La fecha de nacimiento de la madre debe ser la misma que se encuentre asentada en su Acta de Nacimiento, por lo que se recomienda copiarla directamente de este documento o en su defecto de la identificación oficial o comprobante de identidad que presente.
- La fecha debe ser anotada en el formato DD/MM/AAAA, completando ceros a la izquierda si el número del día y/o mes es de un dígito.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Cuando se desconozca la fecha de nacimiento de la madre, ya sea completa o una parte de ella, se debe anotar '| 9 | 9 |' para el día, '| 9 | 9 |' para el mes y '| 9 | 9 | 9 | 9 |' para el año.

Fecha conocida



Fecha desconocida



4. EDAD

Anotar en el espacio correspondiente los años cumplidos de la madre, a partir de su fecha de nacimiento y hasta el momento de la expedición del Certificado de Nacimiento del nacido vivo.

- Cuando se desconozca la edad de la madre, se debe anotar '99'.

Edad conocida.

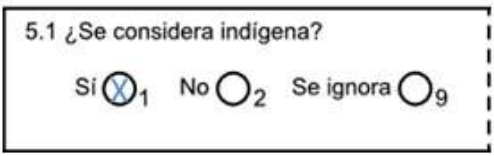


Edad desconocida



5.1 ¿Se considera indígena?

- Elegir **"Si"**, para el caso en que la madre se reconozca o pertenezca a una población indígena. En caso contrario seleccionar la opción **"No"**.
- Si esta información se desconoce, elegir la opción "Se ignora".



5.2 ¿Habla alguna lengua indígena?

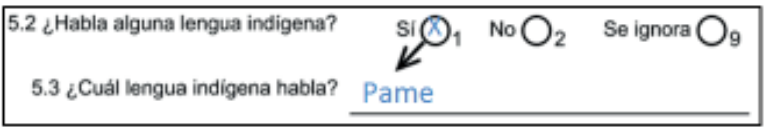
Independientemente si la madre habla español o no se considera perteneciente a una población indígena.

- Elegir **"Si"**, para el caso en que la madre hable alguna lengua indígena. En caso contrario seleccionar la opción **"No"**.
- Si se elige la opción **"Sí"**, pasar a la pregunta 5.3, en caso contrario omitir la respuesta de 5.3, pasando a la pregunta 6.
- Si esta información se desconoce, elegir la opción **"Se ignora".**

5.3 ¿Cuál lengua indígena habla?

Aplica sólo para respuesta afirmativa en la pregunta 5.2.

- Registre el nombre de la lengua indígena (Maya, Náhuatl, Zapoteco, Mazahua, etc.)
- Debe quedar en blanco cuando en la pregunta 5.2 se haya seleccionado la opción **"No"** o **"Se ignora"**.



6. ESTADO CONYUGAL

Es la situación conyugal en que se encuentra la madre al momento de la expedición del Certificado, se incluyen tanto las situaciones de derecho como de hecho.

- Leer todas las posibles respuestas a la madre antes de seleccionar una opción.
- En caso de que esta información se desconozca, elegir la opción **"Se ignora"**.
- Advertir a la madre que en el Registro Civil será verificado su estado conyugal y en caso de no coincidir con el asentado en el Certificado, tendrá contratiempos para el trámite del Acta de Nacimiento respectiva.



7. RESIDENCIA HABITUAL

Anotar el domicilio completo que permita la ubicación de la vivienda donde la madre reside con el propósito de establecerse en ella (se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él); a falta de éste, anotar el domicilio de la vivienda donde pueda ser localizada.

- En la medida de lo posible evite anotar 'Domicilio Conocido', ya que esto dificultará el seguimiento de los programas de salud.

- En caso de desconocer la información correspondiente a cualquier campo de esta pregunta, escribir la leyenda "**Se ignora".**
- Informar a la madre la importancia de proporcionar veraz y correctamente su domicilio de residencia habitual, dado que de esto dependerá el seguimiento oportuno que pueda proporcionársele a su hijo(a) para completar su esquema de vacunación y con ello evitar la presencia posterior de enfermedades prevenibles.
- Si requiere de mayor especificación de los componentes y características de la información que constituye el Domicilio Geográfico, consultar la 'Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos' (INEGI-DOF 12/XI/2010).

7.1 Tipo de vialidad

Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad en función del tránsito vehicular y/o peatonal.

- No se deben usar abreviaturas.
- Ejemplo: Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Callejón, Cerrada, Circuito, Circunvalación, Continuación, Corredor, Diagonal, Eje Vial, Pasaje, Peatonal, Periférico, Privada, Prolongación, Retorno, Viaducto, entre otros.

7.2 Nombre de la vialidad

Sustantivo propio que identifica a la vialidad, es decir, cómo se llama la vialidad.

- No se deben usar abreviaturas.
- Ejemplo: Licenciado Benito Juárez, Las Flores, Rio Blanco, Paseo de la Reforma, Oriente 112, Poniente 12 A, entre otros.

7.3 Núm. Exterior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una vialidad.

- Ejemplo: 125, 1098, 572-A, Manzana 15, Lote 23, 57 Bis, entre otros.

7.4 Núm. Interior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior.

- Ejemplo: 2, Local C, L-5, B, entre otros.

7.5 Tipo de asentamiento humano

Clasificación que se da al asentamiento humano.

- Ejemplo: Aeropuerto, Ampliación, Barrio, Cantón, Ciudad, Ciudad Industrial, Colonia, Condominio, Conjunto Habitacional, Corredor Industrial, Coto, Cuartel, Ejido, Fraccionamiento, Granja, Hacienda, Ingenio, Manzana, Paraje, Parque Industrial, Privada, Prolongación, Pueblo, Puerto, Ranchería, Rancho, Región, Residencia, Rinconada, Sección, Sector, Unidad, Habitacional, Villa, Zona Federal, Zona Industrial, entre otros.
- Privilegiar el registro de 'Colonia' sobre los demás tipos de asentamiento humano, siempre que esta exista.

7.6 Nombre de asentamiento humano

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano.

- Ejemplo: Jardines del Lago, Centro, Villas Taurinas, Parque Residencial Coacalco, Alce Blanco, entre otros.

7.7 Código postal

Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, correspondiente a la residencia habitual de la madre.

- Ejemplo: 20267, 30487, 06600, entre otros.
- Anotar un dígito en cada espacio.

7.8 Localidad

Registrar el nombre de la localidad correspondiente a la residencia habitual de la madre.

- Ejemplo: Ensenada, Santa Mónica, Villa de Arteaga, entre otros.

- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda **"Se ignora".**

7.9 Municipio o delegación

Registrar el nombre del municipio o delegación (para el caso del Distrito Federal) correspondiente a la residencia habitual de la madre.

- Ejemplo: Calvillo, Jerez, Acuña, Benito Juárez, Apodaca, Cuauhtémoc, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda **'Se ignora'.**

7.10 Entidad Federativa

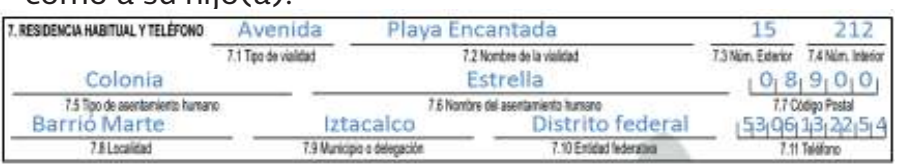
Anotar el nombre de la entidad federativa que corresponde a la residencia habitual de la madre.

- Ejemplo: Morelos, Baja California Sur, Colima, entre otros.
- En caso de que la madre resida en el extranjero, anotar el nombre del país donde reside la madre. Ejemplo: Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Nicaragua, España, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda **'Se ignora'.**

7.11 Teléfono

Número telefónico donde se pueda localizar a la madre del nacido vivo.

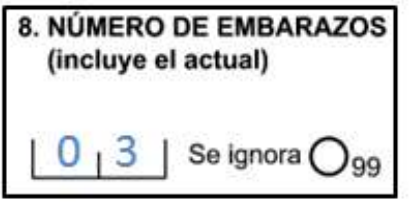
- El número telefónico debe ser anotado a 10 dígitos, uno en cada espacio.
- Informar a la madre la importancia de proporcionar veraz y correctamente su número telefónico, para facilitar el seguimiento de los programas de salud dirigidos tanto a ella, como a su hijo(a).



8. NÚMERO DE EMBARAZOS

Anotar el número del total de embarazos (gestas) que ha tenido la madre a lo largo de su vida sin importar el término de los mismos; es decir, incluyendo: productos nacidos vivos, productos nacidos muertos, abortos, molas y embarazos ectópicos, se debe incluir el embarazo del nacido vivo que se está certificando.

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Si esta información se desconoce, elegir la opción **"Se ignora".**



Nota: Cuando el producto de un embarazo sea gemelar o múltiple, en las preguntas 9, 10 y 11, se debe respetar el orden de nacimiento al momento de la certificación con base en la hora de nacimiento de cada producto.

9. NÚMERO DE HIJOS (AS)

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Si esta información se desconoce, elegir la opción **"Se ignora"**.

9.1 Nacidos muertos (as)

Anotar el número total de productos nacidos muertos (defunciones fetales) que haya tenido la madre. Incluyendo: abortos, molas y embarazos ectópicos.

- Ver definición de "Defunción fetal" en el Glosario de Términos de éste manual.
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Si no ha tenido hijos(as) nacidos(as) muertos(as) anotar '00', no dejar espacios en blanco.
- Si esta información se desconoce, elegir la opción **"Se ignora"**.

9.2 Nacidos vivos (as) (incluye al actual)

Registrar el número total de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) que haya tenido la madre incluyendo al que se está certificando, independientemente que alguno de éstos después falleciera.

9.3 Sobrevivientes

Registrar cuántos de los hijos(as) nacidos(as) vivos(as) anotados en la pregunta 9.2 viven actualmente, incluyendo al que se está certificando.



10. EL (LA) HIJO (A) ANTERIOR NACIÓ

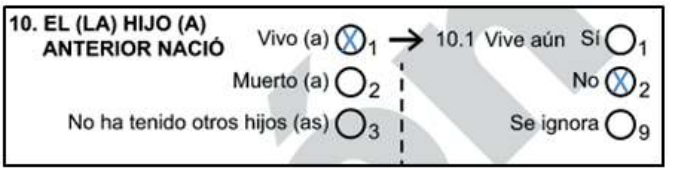
Indicar la condición de supervivencia del (de la) hijo(a) anterior, independientemente si se trata de un embarazo múltiple.

- Si es el primer embarazo de la madre y fue un parto único, elegir la opción 3 que indica que 'no ha tenido hijos(as)' anteriores.
- Si el(la) hijo(a) anterior:
  - nació vivo(a), elegir la opción 1.
  - nació muerto(a), elegir la opción 2.
- Si se elige la opción "Vivo(a)" pasar a la pregunta 10.1, en caso contrario omitir la respuesta de 10.1 y pasar a la pregunta.

10.1 Vive aún

Si el (la) hijo(a) inmediato anterior nació vivo(a), anotar su condición de supervivencia.

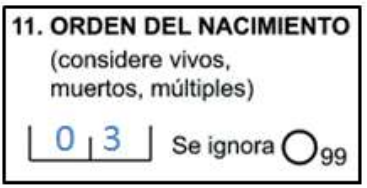
- Si el(la) hijo(a) anterior vive elegir la opción **"Sí",** en caso contrario elegir opción **"No".**
- Si esta información se desconoce, elegir la opción **"Se ignora".**
- Si la madre no ha tenido otros(as) hijos(as) o el(la) anterior nació muerto(a), omitir la respuesta.



11. ORDEN DEL NACIMIENTO (considere productos vivos, muertos y múltiples).

Anotar la posición (orden numérico) que ocupa el nacido vivo que se está certificando en relación al total de nacimientos anteriores que la madre haya tenido, considerándolo para tal efecto en último lugar.

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Para obtener el orden del nacimiento se deben considerar: nacidos vivos (independientemente de que a la fecha de expedición del Certificado estén vivos o no), nacidos muertos (incluyendo abortos, molas y ectópicos) y los productos de partos múltiples se deben contar independientemente.
- La cifra registrada en esta pregunta debe coincidir con la suma del número de hijos nacidos vivos (pregunta 9.2) y del número de nacidos muertos (pregunta 9.1).
- Si esta información se desconoce, elegir la opción “Se ignora”.



Ejemplo de registro correcto de la pregunta 8 a la 11 para un embarazo gemelar, suponiendo que es un primer embarazo y ambos productos nacieron vivos:

Datos del primer gemelo



Datos del segundo gemelo



12. ATENCIÓN PRENATAL

Debe considerar toda aquella atención recibida por un profesional de la salud (incluyendo parteras profesionales) en el periodo de gestación, tanto para la vigilancia y control del embarazo, como la otorgada para la consulta de problemas relacionados con el mismo.

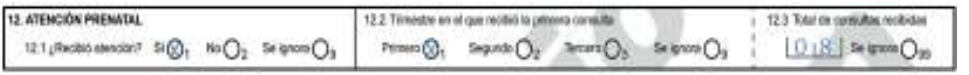
- No debe considerarse la atención otorgada por parteras tradicionales u otras personas no profesionales de la salud.
- Se debe tomar en cuenta toda atención recibida independientemente del lugar donde se le haya brindado (unidad médica regional, hospital, clínica particular, centro de salud, unidad móvil de salud, etc.).
- Si se desconoce la información de cualquiera de las preguntas de la 12.1 a la 12.3, elegir la opción **"Se ignora".**
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.

12.1 ¿Recibió atención prenatal? registrar si la madre recibió atención prenatal por un profesional de la salud (médico, enfermera, partera profesional, etc.) durante su embarazo.

- Si la madre recibió atención prenatal por un profesional de la salud, elegir la opción **"Sí",** en caso contrario elegir opción **"No".**
- Si se elige la opción "**Sí**" pasar a la pregunta 12.2, en caso contrario omitir la respuesta de 12.2 y 12.3, pasando a la pregunta 13.

12.2 Trimestre en el que recibió la primera consulta. Si se respondió afirmativamente la pregunta 12.1, indicar dentro de que trimestre de la gestación recibió la primera consulta prenatal.

12.3 Total de consultas recibidas. Si se respondió afirmativamente la pregunta 12.1, anotar el número total de consultas de atención prenatal que recibió la madre durante su embarazo, en caso contrario anotar 0 (cero).



13. ¿VIVE LA MADRE DEL NACIDO (A) VIVO (A)?

- Verificar y registrar si la madre del nacido vivo que se está certificando vive al momento de la expedición del Certificado de Nacimiento.
- Seleccionar la opción **"No"**, sólo en caso de que la madre haya fallecido antes de la expedición del Certificado de Nacimiento y por ningún motivo omitir la respuesta de la pregunta 13.1.
- Si seleccionó la opción **"Sí",** se debe dejar en blanco la pregunta 13.1 y pasar a la pregunta 14.
- 13.1 En caso negativo, escriba el número de folio del Certificado de Defunción. Si la madre del nacido vivo falleció antes de la expedición del Certificado de Nacimiento anotar el número correcto del Certificado de Defunción expedido para la madre.
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- El folio del Certificado de Defunción es un número de 9 dígitos, el cual se ubica en la parte superior derecha de dicho documento.
- Si no se tiene el Certificado de Defunción a la mano, localice la tercera copia de este documento (hoja verde) en la historia clínica de la madre o bien, solicite a los familiares el original (hoja blanca) para transcribir el folio.
- Si seleccionó la opción **"Sí"** en 13, dejar en blanco esta pregunta y pasar a la 14.



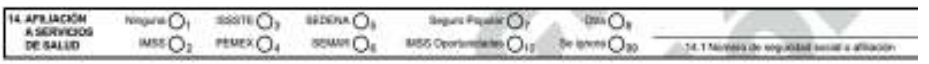
14. AFILIACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

Elegir la opción que corresponda a la institución donde está afiliada la madre o de la cual es derechohabiente.

- Admite hasta 2 respuestas, debido a que la madre puede estar afiliada o ser derechohabiente en más de una institución.
- Es importante leer todas las opciones y elegir las señaladas por la madre o el informante.
- Cuando la madre no tiene afiliación a los Servicios de Salud, seleccionar la opción **"Ninguna"** y omitir la respuesta de la pregunta 14.1 dejándola en blanco.
- Si se desconoce la información, elegir la opción **"Se ignora"** y omitir la respuesta de la pregunta 14.1 dejándola en blanco.

14.1 Número de Seguridad Social o Afiliación. Cuando la madre tenga al menos una afiliación o derechohabiencia a algún servicio de salud, anotar el número de seguridad social o afiliación de la institución respectiva.

- Para el caso en el que la madre esté afiliada a más de una institución, anotar el número de afiliación de la opción correspondiente a la institución donde se atendió el parto. Si la madre no fue atendida por alguna de las instituciones a las que está afiliada, anotar el número de afiliación de la institución de la cual la madre recibe las mayores prestaciones o en su defecto de la primera opción seleccionada.
- Debe quedar en blanco cuando en la pregunta 14 se haya seleccionado la opción **"Ninguna"** o **"Se ignora"**.



15. ESCOLARIDAD

Elegir la opción que indique el grado de estudios de la madre.

- Si la madre manifiesta tener una escolaridad, indique en 15.1 si esta es completa o incompleta.

- Si la madre no cuenta con estudios, seleccione la opción **"Ninguna"** y no responder 15.1.
- Si se desconoce la información, elegir la opción **"Se ignora"** y no responder 15.1.

15.1 El grado anterior es

Si la madre manifiesta tener algún nivel de estudio completo marque en 15.1 la opción **"Completa"**, en caso de que no haya concluido el grado mencionado marque la opción 'Incompleta'.



16. OCUPACIÓN HABITUAL

Anotar el oficio o trabajo de la madre al momento de la expedición del Certificado. Ejemplo: maestra, secretaria, mesera, enfermera, etc.

- Si la madre no trabaja, mencionar a que se dedica, cuál es su ocupación principal. Ejemplo: estudiante, ama de casa, jubilada, etc.
- No utilizar abreviaturas.
- Si se desconoce la información, elegir la opción **"Se ignora"**.

16.1 Trabaja actualmente.

Elegir la opción **"Sí",** cuando la madre cuente con un trabajo, labore en un negocio familiar o por su cuenta, independientemente de que perciba o no ingresos.

2. Datos del nacido vivo y del nacimiento

Cuando el nacimiento ocurre en una unidad médica, ninguna de las preguntas de este apartado debe quedar sin respuesta, a excepción de la pregunta 18. SEXO cuando por alguna anomalía no sea posible definir el sexo del nacido vivo al momento de su nacimiento.

Además, si el nacimiento se atendió fuera de una unidad médica (por una Partera u otra persona) las preguntas 22.1 APGAR y 22.2 SILVERMAN podrán quedar sin respuesta y en la pregunta 30. DOMICILIO DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO será válido ignorar algún campo, excepto la entidad de ocurrencia.

17. FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO

Anotar el día, mes, año y hora de ocurrencia del nacimiento del nacido vivo que se está certificando.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin datos, ni llenarse los espacios con nueves.
- La fecha debe ser anotada en el formato DD/MM/AAAA, completando ceros a la izquierda si el número del día y/o del mes es de un dígito.
- La hora debe ser anotada en el formato HH:MM, utilizando la escala de 24 horas y completando ceros a la izquierda si el número correspondiente a la hora o a los minutos es de un dígito.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.



18. SEXO

Indicar el sexo que corresponde al nacido vivo.

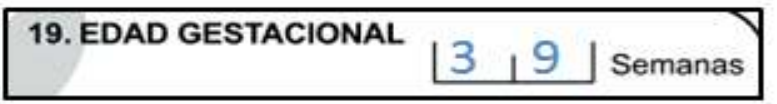
- Para el caso en que no sea posible definir el sexo del nacido vivo, dejar en blanco esta pregunta y especificar en la pregunta 26 la posible anomalía congénita relacionada.



19. EDAD GESTACIONAL

Anotar la edad gestacional del nacido vivo expresada en semanas completas, utilizando como método de cálculo la valoración Capurro (consultar detalle en el "GLOSARIO DE TÉRMINOS"), en caso que dicha técnica no pueda ser aplicada, calcular las semanas contando a partir del primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha de ocurrencia del nacimiento.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin datos, ni llenarse los espacios con nueves.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).



20. TALLA

- Registrar en centímetros la distancia entre el talón y el vértice de la cabeza del nacido vivo.
- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin datos, ni llenarse los espacios con nueves.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).



21. PESO AL NACER

Anotar el peso del nacido vivo al nacer, expresado en gramos.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin datos, ni llenarse los espacios con nueves.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).
- Completar con cero a la izquierda si el peso es menor a 1000 gramos.
- 1 kilo = 1000 gramos. Ejemplo: si el nacido vivo pesa 3 kilos 400 gramos se debe anotar:



22.1 APGAR (a los cinco minutos)

Registrar la calificación obtenida por el nacido vivo, de acuerdo a las condiciones generales de salud presentadas a los 5 minutos del nacimiento.

- Esta calificación se determina valorando cinco criterios simples: coloración de la piel, frecuencia cardiaca, irritabilidad refleja, tono muscular y esfuerzo respiratorio. Consultar el "GLOSARIO DE TÉRMINOS" para el detalle de la medición.
- La puntuación final tiene una escala de 0 a 10, donde el 0 indica un estado patológico y el 10 un buen estado de salud.
- Completar con cero a la izquierda si la calificación final es de un dígito.

22.2 SILVERMAN (a los cinco minutos)

Registrar la calificación obtenida por el nacido vivo, de acuerdo a la evaluación de su función respiratoria realizada a los 5 minutos del nacimiento.

- Esta calificación se determina a través de cinco parámetros: quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción xifoidea, aleteo nasal y movimiento toraco-abdominal. Consultar el 'GLOSARIO DE TÉRMINOS' para el detalle de la medición.

- La puntuación final tiene una escala de 10 a 0, donde el 10 un estado patológico del producto y 0 indica un buen estado de salud al momento del nacimiento.
- Completar con cero a la izquierda si la calificación final es de un dígito.



23. TAMIZ AUDITIVO

Anotar si se realizó o no al nacido vivo la prueba del tamiz auditivo, marcando la opción que corresponda según sea el caso.



24. APLICACIÓN DE VACUNAS Y COMPLEMENTOS

Verificar para cada opción si la vacuna o complemento fue aplicado al nacido vivo, marcando posteriormente la opción que corresponda según sea el caso.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin respuesta o en blanco.
- Si el certificante no está informado sobre si se aplicaron o no las vacunas y/o vitaminas al nacido vivo, debe contactar al área responsable para que le informe.
- En el caso que no se le haya aplicado al nacido vivo alguna vacuna o vitamina, independientemente de que esto se deba a un desabasto, elegir la opción 'No' donde corresponda.



25. PRODUCTO DE UN EMBARAZO

Indicar si el nacido vivo es producto de un embarazo único, gemelar, de tres o más.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin respuesta.
- En caso de ser un parto gemelar o de tres o más, considerar el total de productos de la gesta, independientemente de su condición de supervivencia; es decir, todos los productos deben ser tomados en cuenta a pesar de que uno o más hayan nacido muertos, o hayan fallecido antes de la expedición del Certificado.



Nota: Si el embarazo es gemelar o de tres o más, se debe expedir un Certificado de Nacimiento para cada producto nacido vivo, respetando el orden de acuerdo a la hora de nacimiento.

26. ANOMALÍAS CONGÉNITAS, ENFERMEDADES O LESIONES DEL NACIDO VIVO

Si el nacido vivo presenta malformaciones congénitas, lesiones, así como afecciones originadas en el periodo perinatal, anotar en el espacio correspondiente la patología.

- Anotar sólo una patología por cada renglón.
- En caso de detectarse una segunda patología, debe registrarse en primer lugar la que ponga en mayor riesgo la vida del nacido vivo.
- Por ningún motivo puede dejarse en blanco esta variable. Si el nacido vivo no presenta patologías, se debe especificar anotando la frase **'Ninguna aparente'** en ambos renglones.
- Respetar el espacio designado para anotar el código CIE que corresponde a la patología descrita.



Nota: Previo a la captura del Certificado de Nacimiento en el SINAC, personal especializado debe asignar el código correspondiente a cada patología registrada en este apartado, de acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE).

27. RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO

Elegir la opción que corresponda al procedimiento que se utilizó para la resolución del embarazo, indicando si fue parto normal (eutócico), con complicaciones (distócico), cesárea o algún otro procedimiento.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin respuesta.
- Si se seleccionó 'Distócico' debe elegir si se utilizaron fórceps o no, en el espacio asignado para ello.
- En caso de elegir la opción 'Otro', especificar en el espacio contiguo, sin utilizar abreviaturas, que procedimiento se utilizó.



28. SITIO DE ATENCIÓN DEL PARTO

Indicar el sitio donde ocurrió el nacimiento, si fue en una unidad médica pública o privada, en la vía pública, en el hogar u otro lugar.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin respuesta.
- Si el nacimiento ocurrió en una unidad médica, sea pública o privada (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, IMSS Oportunidades u otra unidad pública), elegir la opción correspondiente y pasar a las preguntas 28.1 y 28.2, las cuales no pueden quedar sin respuesta.

- En caso de que el nacimiento haya ocurrido en la vía pública, en el hogar o en otro lugar, las preguntas 28.1 y 28.2 deben dejarse en blanco.

28.1 Nombre de la unidad médica. Especificar el nombre oficial de la unidad médica en la que ocurrió el nacimiento.

- No utilizar abreviaturas.
- Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica, omitir la respuesta.

Cuando el evento haya ocurrido Fuera de la Unidad Médica (opciones 11, 12 y 13) considerar lo siguiente:

11. Hogar.- Seleccionar esta opción solo cuando el evento haya ocurrido en el domicilio de la madre o de algún familiar de la misma.

12. Vía Pública.- Seleccionar esta opción cuando el evento haya ocurrido en un espacio público por donde transiten peatones o circulen vehículos. Por ejemplo: calle, avenida, carretera, camino, plaza, parque, etc.

13. Otro Lugar.- Seleccionar esta opción cuando el evento haya ocurrido en un sitio distinto a los incluidos en las opciones 11 y 12. Por ejemplo: una ambulancia, un inmueble público o privado, teatro, cine, dentro de un transporte público o privado, centro comercial, domicilio de un médico o partera, etc.

28.2 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Registrar la CLUES correspondiente a la unidad médica donde ocurrió el nacimiento.

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Si esta información se desconoce, consultar al área de estadística de la unidad médica para obtenerla.
- Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica omitir la respuesta.



29. PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO

Indicar la opción que identifique a la persona que atendió el parto.

- Esta información no puede desconocerse y no debe dejarse sin respuesta.

- Si el parto fue atendido por un médico marque la opción 'Médico' y enseguida seleccione el tipo de médico (Gineco-obstetra, Otro especialista, Residente, General, Médico Pasante en Servicio Social -MPSS- o Médico Interno de Pregrado -MIP-).

- Si el parto no fue atendido por un 'Médico', seleccione la opción que corresponda.

- En caso de seleccionar alguna opción con '*' ('Otro especialista', 'Persona autorizada por la Secretaría de Salud' y 'Otro'), especifique en el espacio asignado para ello, sin utilizar abreviaturas.



30. DOMICILIO DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO

Anotar el domicilio completo del lugar donde ocurrió el nacimiento.

- Evite anotar 'Domicilio Conocido'.

- En caso de desconocer la información correspondiente a cualquier campo de esta pregunta, escribir la leyenda 'Se ignora'.

- Si requiere de mayor especificación de los componentes y características de la información que constituye el Domicilio Geográfico, consultar la 'Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos' (INEGI-DOF 12/XI/2010).

30.1 Tipo de vialidad

Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad en función del tránsito vehicular y/o peatonal.

- No se deben usar abreviaturas.
- Ejemplo: Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Callejón, Cerrada, Circuito, Circunvalación, Continuación, Corredor, Diagonal, Eje Vial, Pasaje, Peatonal, Periférico, Privada, Prolongación, Retorno, Viaducto, entre otros.

30.2 Nombre de la vialidad

Sustantivo propio que identifica a la vialidad, es decir, cómo se llama la vialidad.

- No se deben usar abreviaturas.
- Ejemplo: Licenciado Benito Juárez, Las Flores, Rio Blanco, Paseo de la Reforma, Oriente 112, Poniente 12 A, entre otros.

30.3 Núm. Exterior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una vialidad.

- Ejemplo: 125, 1098, 572-A, Manzana 15, Lote 23, 57 Bis, entre otros.

30.4 Núm. Interior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior.

- Ejemplo: 2, Local C, L-5, B, entre otros.

30.5 Tipo de asentamiento humano

Clasificación que se da al asentamiento humano.

- Ejemplo: Aeropuerto, Ampliación, Barrio, Cantón, Ciudad, Ciudad Industrial, Colonia, Condominio, Conjunto Habitacional, Corredor Industrial, Coto, Cuartel, Ejido, Fraccionamiento, Granja, Hacienda, Ingenio, Manzana Paraje, Parque Industrial,

Privada, Prolongación, Pueblo, Puerto, Ranchería, Rancho, Región, Residencia, Rinconada, Sección, Sector, Unidad, Habitacional, Villa, Zona Federal, Zona Industrial, entre otros

- Privilegiar el registro de 'Colonia' sobre los demás tipos de asentamiento humano, siempre que esta exista.

30.6 Nombre del asentamiento humano

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano.

- Ejemplo: Jardines del Lago, Centro, Villas Taurinas, Parque Residencial Coacalco, Alce Blanco, entre otros.

30.7 Código Postal

Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos.

- Ejemplo: 20267, 30487, 06600, entre otros.
- Anotar un dígito en cada espacio.

30.8 Localidad.

Registrar el nombre de la localidad correspondiente al domicilio donde ocurrió el nacimiento.

- Ejemplo: Ensenada, Santa Mónica, Villa de Arteaga, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda "Se ignora".

30.9 Municipio o delegación.

Registrar el nombre del municipio o delegación (para el caso del Distrito Federal) correspondiente al domicilio donde ocurrió el nacimiento.

- Ejemplo: Calvillo, Jerez, Acuña, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Apodaca, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda 'Se ignora'.

30.10 Entidad Federativa.

Anotar el nombre de la entidad federativa correspondiente al domicilio donde ocurrió el nacimiento.

- Ejemplo: Morelos, Baja California Sur, Colima, entre otros.



3. Datos del certificante

Las preguntas de esta sección corresponden a los datos de identificación de la persona que expide el Certificado de Nacimiento, así como de la unidad médica en la que éste se expidió en caso que el nacimiento no haya ocurrido en la misma.

- Por ningún motivo deberán dejarse sin respuesta las preguntas de esta sección.
- Los datos que aquí se solicitan son de suma importancia para realizar cualquier aclaración posterior.

31. NOMBRE

Anotar con letra de molde el nombre completo de la persona que certifica el nacimiento, iniciando por el(los) nombre(s), seguido de los apellidos.

- No utilizar abreviaturas, a menos que se encuentren asentadas en el Acta de Nacimiento del certificante.



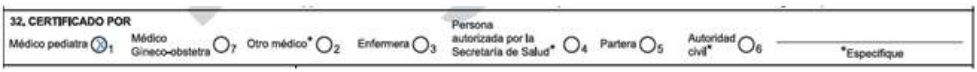
32. CE RTIFICADO POR

Elegir la opción que identifique a la persona que certifica el nacimiento.

- En caso de seleccionar la opción con '*' ('Otro médico', 'Persona autorizada por la Secretaría de Salud' o 'Autoridad

civil'), especificar en el espacio correspondiente sin utilizar abreviaturas.

- Si el Certificado es llenado por un médico pasante, elegir la opción 'Persona autorizada por la Secretaría de Salud' y anotar 'Médico Pasante' en la línea para especificar.



33. SI EL CERTIFICANTE ES MÉDICO

Cuando la persona que certifica el nacimiento es médico (opciones 1, 2 y 7 de la pregunta 32), anotar en el espacio correspondiente el número de cédula profesional que lo avala como tal.

- Si el certificante no es médico, omitir la respuesta.
- Si el certificante es médico pasante anotar 'En trámite'



33. UNIDAD MÉDICA QUE PROPORCIONÓ EL CERTIFICADO SI EL NACIMIENTO OCURRIÓ FUERA DE UNA UNIDAD MÉDICA

Cuando el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del SNS y/o fue atendido por personal no facultado para la expedición del Certificado de Nacimiento:

- Si la madre recibió atención prenatal en una unidad médica de alguna institución del SNS, a solicitud de la madre, dicha institución es la responsable de expedir el Certificado, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por el certificante. En este caso anotar la CLUES de la unidad médica.
- Si la madre no recibió atención prenatal, es responsabilidad de los SESA establecer los mecanismos que garanticen la expedición del Certificado de Nacimiento, siempre y cuando el vínculo madre-hijo(a) pueda ser corroborado por el certificante. En este caso si el Certificado fue expedido en una unidad médica, anotar la CLUES respectiva.

- La respuesta a esta pregunta debe omitirse cuando el nacimiento haya ocurrido en una unidad médica, ya sea pública o privada.

34.1 Nombre de la unidad médica.

Especificar el nombre oficial de la unidad médica que expide el Certificado de Nacimiento, siempre y cuando el nacimiento haya ocurrido fuera de una unidad médica del SNS.

- No utilizar abreviaturas.

34.2 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES).

Registrar la CLUES correspondiente a la unidad médica que expide el Certificado de Nacimiento, siempre y cuando el nacimiento haya ocurrido fuera de una unidad médica del SNS.

- Colocar un sólo dígito en cada espacio.
- Si se desconoce la información, consultar al área de estadística de la unidad médica para obtenerla.



35. DOMICILIO Y TELÉFONO

Anotar el domicilio completo donde se localiza habitualmente la persona que certifica el nacimiento, así como el número telefónico donde se le puede localizar.

- Esta información no podrá ser ignorada ni omitida.
- En caso de que el nacimiento haya ocurrido en una unidad médica y el certificante esté adscrito a ésta, anotar los datos del domicilio de la misma.
- Los datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos de Protección de Datos Personales.

- Si requiere de mayor especificación de los componentes y características de la información que constituye el Domicilio Geográfico, consultar la 'Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos' (INEGI-DOF 12/XI/2010).

35.1 Tipo de vialidad

Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o peatonal.

- Ejemplo: Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Callejón, Cerrada, Circuito, Circunvalación, Continuación, Corredor, Diagonal, Eje Vial, Pasaje, Peatonal, Periférico, Privada, Prolongación, Retorno, Viaducto, entre otros.

35.2 Nombre de la vialidad

Sustantivo propio que identifica a la vialidad, es decir, cómo se llama la vialidad.

- No se deben usar abreviaturas.
- Ejemplo: Licenciado Benito Juárez, Las Flores, Rio Blanco, Paseo de la Reforma, Oriente 112, Poniente 12 A, entre otros.

35.3 Núm. Exterior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una vialidad.

- Ejemplo: 125, 1098, 572-A, Manzana 15, Lote 23, 57 Bis, entre otros.

35.4 Núm. Interior

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior.

- Ejemplo: 2, Local C, L-5, B, entre otros.

35.5 Tipo de asentamiento humano

Clasificación que se da al asentamiento humano.

- Ejemplo: Aeropuerto, Ampliación, Barrio, Cantón, Ciudad, Ciudad Industrial, Colonia, Condominio, Conjunto Habitacional, Corredor Industrial, Coto, Cuartel, Ejido, Fraccionamiento, Granja, Hacienda, Ingenio, Manzana, Paraje, Parque Industrial, Privada, Prolongación, Pueblo, Puerto, Ranchería, Rancho, Región, Residencia, Rinconada, Sección, Sector, Unidad, Habitacional, Villa, Zona Federal, Zona Industrial, entre otros.
- Privilegiar el registro de 'Colonia' sobre los demás tipos de asentamiento humano, siempre que esta exista.

35.6 Nombre del asentamiento humano

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano.

- Ejemplo: Jardines del Lago, Centro, Villas Taurinas, Parque Residencial Coacalco, Alce Blanco, entre otros.

35.7 Código Postal

Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, correspondiente al domicilio del certificante.

- Ejemplo: 20267, 30487, 06600, entre otros.
- Anotar un dígito en cada espacio.

35.8 Localidad.

Registrar el nombre de la localidad correspondiente al domicilio del certificante.

- Ejemplo: Ensenada, Santa Mónica, Villa de Arteaga, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda 'Se ignora'.
- Colocar un sólo dígito en cada espacio.

35.9 Municipio o delegación.

Registrar el nombre del municipio o delegación (para el caso del Distrito Federal) correspondiente al domicilio del certificante.

- Ejemplo: Calvillo, Jerez, Acuña, Benito Juárez, Apodaca, Cuauhtémoc, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda 'Se ignora'.

35.10 Entidad Federativa.

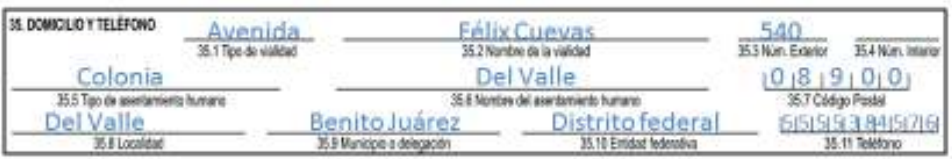
Anotar el nombre de la entidad federativa correspondiente al domicilio del certificante.

- Ejemplo: Morelos, Baja California Sur, Colima, entre otros.
- En caso de que la madre resida en el extranjero, anotar el nombre del país donde reside la madre. Ejemplo: Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Nicaragua, España, entre otros.
- Si se desconoce esta información, anotar la leyenda 'Se ignora'.

35.11 Teléfono

Número telefónico donde se pueda localizar al certificante.

- El número telefónico debe ser anotado a 10 dígitos, uno en cada espacio.
- Informar a la madre la importancia de proporcionar veraz y correctamente su número telefónico, para facilitar el seguimiento de los programas de salud dirigidos tanto a ella, como a su hijo(a).



36. FIRMA

La persona que certifica el nacimiento debe plasmar su firma autógrafa en este espacio, haciendo constar que es el responsable de la información contenida en el documento. Para el caso del CEN, el certificante firmará el mismo electrónicamente, de acuerdo a lo establecido en el eSINAC.

- El Certificado se considerará inválido sin ésta firma.
- El certificante debe firmar en original cada uno de los 3 tantos que componen el Certificado de Nacimiento.
- Utilizar únicamente BOLÍGRAFO. No usar plumas con tinta de gel, pluma fuente, plumón o similares.

37. FECHA DE CERTIFICACIÓN

Anotar el día, mes y año correspondiente a la fecha en la que el Certificado es expedido.

- Por ningún motivo debe confundirse con la fecha en la que el Certificado es entregado a la madre.
- Esta información no puede desconocerse, dejarse sin datos, ni llenarse los espacios con nueves.
- La fecha debe ser anotada en el formato DD/MM/AAAA, completando ceros a la izquierda si el número del día y/o del mes es de un dígito.
- Utilizar números arábigos (0, 1, 2, ... , 9).



Nota: Si el nacimiento ocurrió en una unidad médica, el Certificado debe expedirse dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento.

4. Otros Metodos de Identificación

En esta sección se plasman los elementos que permiten la identificación de la madre y del nacido vivo, así como de la unidad médica que avala la certificación.

SIN ESTA INFORMACIÓN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO NO TIENE VALIDEZ

Consulte las siguientes excepciones:

Huella del pie derecho del nacido vivo

Plasmar la huella de la planta del pie derecho del nacido vivo.

- No se requiere una tinta especial.
- En caso de que el nacido vivo no cuente con la extremidad derecha, plasme la huella de la planta del pie izquierdo. Si carece de ambos, colocar una 'X'.
- Al plasmar la huella evite encimarla con la firma del certificante (variable 36) o invadir el espacio para la misma.
- Cuando el Certificado no haya sido expedido de manera oportuna, la huella del pie del nacido vivo NO aplicará pasados 365 días naturales posteriores al nacimiento.

Huella del dedo pulgar derecho de la madre

Plasmar la huella del dedo pulgar de la mano derecha de la madre.

- No se requiere una tinta especial.
- En caso de que la madre no cuente con la extremidad derecha, plasme la huella del dedo pulgar de la mano izquierda. Si carece de ambos, colocar una "X".
- Al plasmar la huella evite encimarla con la firma de la madre o invadir el espacio para la misma.
- Si la madre falleció, este espacio debe quedar en blanco, debiendo anexar una copia fotostática del Certificado o del Acta de Defunción.

- En el caso extraordinario de que el nacido vivo se encuentre en situación de desamparo, este espacio debe quedar en blanco.

Firma de la madre

Solicitar a la madre del nacido vivo que registre su firma.

- Previo a la firma de la madre, ésta debe revisar el contenido del Certificado y manifestar su conformidad con la información anotada. Cuando la madre no sepa leer y escribir, el certificante
- La madre debe firmar en original cada uno de los 3 tantos que componen el Certificado de Nacimiento para tener mejor legibilidad de la firma.
- Si la madre no sabe leer y escribir, en este espacio debe plasmarse nuevamente la huella del pulgar de la mano derecha.
- Utilizar únicamente BOLÍGRAFO. No usar plumas con tinta de gel, pluma fuente, plumón o similares.
- Si la madre falleció, este espacio debe quedar en blanco, debiendo anexar una copia fotostática del Certificado o del Acta de Defunción.
- En el caso extraordinario de que el nacido vivo se encuentre en situación de desamparo, este espacio debe quedar en blanco.

Sello oficial de la Unidad Médica que certificó

Si el Certificado es expedido en una unidad médica, plasmar el sello oficial de la misma. Para el caso del CEN, el certificante se generara un sello electrónico, de acuerdo a lo establecido en el eSINAC.

- No se requiere una tinta especial.
- Si el Certificado se expidió fuera de una unidad médica no es necesario el sello de la unidad médica, para este caso el espacio debe quedar en blanco.

5. Fe de erratas

En este apartado se pueden realizar correcciones a la información anotada en las tres primeras secciones del Certificado de Nacimiento y con ello evitar cuando sea posible, la cancelación del formato por

error de llenado. La Fe de erratas no se utiliza en el CEN, cuando se tengounoovarioserroresenneste,sedebecancelaryemitirunonuevo.

INSTRUCCIONES

- La FE DE ERRATAS, se encuentra en la parte posterior del Certificado de Nacimiento.
- Solo se pueden corregir 3 errores.
- En caso de que el Certificado de Nacimiento tenga más de 3 errores se debe cancelar y expedir uno nuevo.
- Se debe usar un renglón para cada corrección a realizar.
- Los renglones que no se utilicen se deben cancelar con al menos una raya en diagonal que atraviese todo el renglón.
- Para cada corrección, anotar el número de la pregunta en la que se cometió el error y en el espacio para la 'Corrección' especificar dicho error, indicando lo que dice y debe decir.
- Cuando esta sección sea utilizada:

• Es importante que las correcciones que se realicen al Certificado de Nacimiento original, también deben plasmarse en las 2 hojas restantes (rosa y azul), para que la información modificada quede asentada en los 3 tantos.

• La persona que certificó el nacimiento debe realizar las correcciones, anotando su nombre (Nombre(s) y Apellidos) como responsable de la corrección y firmar en el espacio designado.

• Si el certificante no puede ser localizado para realizar la(s) corrección(es), el Director de la unidad médica será el responsable de realizar las correcciones o en dado caso puede designar a otra persona para este fin (por ejemplo, al representante legal, Jefe de Toco cirugía en turno, etc.).

• Poner el sello oficial de la unidad médica en la parte asignada en la FE DE ERRATAS, dando legalidad a que el Certificado fue corregido por la persona correspondiente.

• En caso de que la certificación se haya realizado y la corregido fuera de una unidad médica, por personal autorizado por la Secretaría de Salud, este sello puede omitirse, por ejemplo:

  - Cuando sea corregido por una partera.
  - Cuando sea un médico particular que no cuente con sello.

- Si al momento de la entrega del Certificado a los interesados no se detecta ningún error, este apartado debe dejarse en blanco, para correcciones necesarias posteriores.

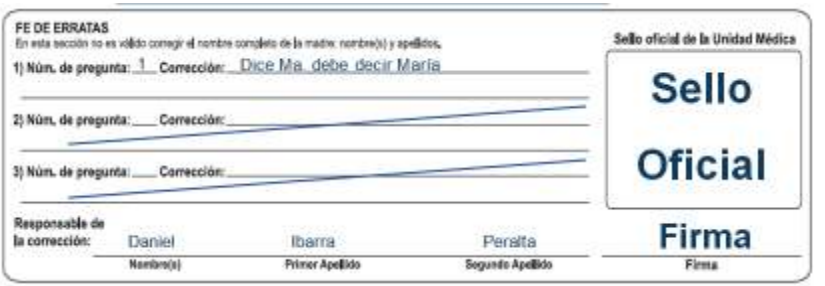
RESTRICCIONES

- Para realizar correcciones en la pregunta "NOMBRE DE LA MADRE", sólo aplicarán cambios debidos a:
  - Errores ortográficos en nombres o apellidos.
  - Errores por anotar los nombres o apellidos con abreviaturas.
  - Errores de omisión al no anotar algún nombre o apellido, cuando la madre tiene más de uno.
- **Por ningún motivo se podrá corregir el nombre completo de la madre (Nombre(s) y Apellidos).**
- Las correcciones realizadas en esta sección serán inválidas si:
  - Si el apartado 'FE DE ERRATAS' no está debidamente firmado y sellado, de acuerdo a las instrucciones antes mencionadas.
  - El formato presenta tachaduras y/o enmendaduras en cualquier parte del mismo.

EJEMPLOS

1. Un error:

- En la pregunta 1, se anotó 'Ma.' Y en el Acta de Nacimiento viene asentado como 'María'.



2. Dos errores:

- En la pregunta 1, se anotó como apellido paterno ‘Espinoza’ y en el Acta de Nacimiento viene asentado como ‘Espinosa’.
- En la pregunta 3, se registró como fecha de nacimiento de la madre: ‘02/03/2014’, cuando la fecha correcta tal como viene en su Acta de Nacimiento, es: ‘02/03/1973’.



IX. Glosario de términos y abreviaturas

Términos.

Aborto.- Interrupción del embarazo en cualquier momento desde la fecundación hasta antes de las 22 semanas completas de gestación. Puede ser espontáneo o provocado.

Acta.- Forma debidamente autorizada por un Juez y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se hace constar un hecho o acto del estado civil.

Acta circunstanciada de hechos.- Documento en el que se hace constar una relatoría de hechos, las circunstancias y forma en que ocurrieron, de tiempo, modo y lugar.

Anomalía congénita.- Toda alteración morfológica o funcional, presente al nacimiento y ocurrida al momento de la concepción o durante el desarrollo del embarazo.

APGAR.- Valoración de APGAR: Primer examen que se realiza al nacido vivo. Método simple y reproducible, generalmente se realiza al minuto y a los cinco minutos posteriores al nacimiento. Se determina valorando cinco criterios simples en una escala que va de cero a dos, y sumando los cinco valores obtenidos. Mientras mayor sea el puntaje, mejor pronóstico para el nacido vivo.

Parámetro	Puntaje		
	0	1	2
Frecuencia Cardiaca	Ausente (sin pulso)	< 100 latidos por minuto	Normal (> 100 latidos por 97inute)
Esfuerzo respiratorio	Ausente (sin respiración)	Respiración lenta o irregular	Normal
Tono muscular	Ninguno,	Ligera flexión	Movimiento
Irritabilidad (respuesta refleja)	Ausente (no responde	Llanto leve al estimularse	Los estornudos y la tos
Apariencia (coloración de la piel)	Coloración azul grisácea o palidez en	Extremidad es azules	Normal

Área responsable de la distribución.- Área designada para la distribución de los formatos del Certificado de Nacimiento por cada entidad federativa y/o Institución del Sector Salud.

Atención Prenatal.- Consultas médicas de vigilancia efectuadas durante la gestación, con el fin de verificar la evolución del embarazo y para asegurar el buen estado de salud de la madre y del (de la) niño (a); o para detectar tempranamente cualquier anomalía y brindar el tratamiento más adecuado.

Aplicación de vitamina A (Retinol).- Se aplica para la prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina A, que puede ocasionar queratomalacia, xerolftamía y ceguera nocturna. En la prevención de las complicaciones del sarampión, entre otros síndromes se encuentra la mala absorción en niños que se alimentan con leche no fortificada.

Aplicación de vitamina K (Fitomenadiona – K1).- Se recomienda administrar de forma rutinaria, inmediatamente después del nacimiento, dosis única de 0.5 – 1 mg., vía IM, para prevenir la enfermedad hemorrágica en el neonato y el aumento de casos de hiperbilirrubinemia.

Capurro.- Este método fue obtenido mediante un estudio protocolizado prospectivo basado en el trabajo de Dubowitz y tiene dos formas de evaluación:

1. Capurro A.

El método está basado en cinco parámetros clínicos y dos parámetro neurológicos y presenta un margen de error de ± 8,4 días cuando es realizado por un explorador entrenado. Los signos que se han de evaluar son los siguientes:

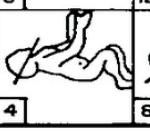
a) Somáticos:

- Formación del pezón.
- Textura de la piel.
- Forma del pabellón auricular.

- Tamaño del nódulo mamario.
- Surcos plantares.

b) Neurológicos:

- Signo de la bufanda.
- Caída de la cabeza.

A SOMATICO K= 204 días	FORMA DEL PEZON.	Pezón-apenas visible. No se visuliza Areola. 0	Pezón bien definido Areola. 0.75 cm. 5	Areola bien definida. No sobresaliente. 0.75 cm. 10	Areola sobresaliente. 0.75 cm. 15	
	TEXTURA DE LA PIEL.	Muy fina Gelatinosa. 0	Fina y Lisa 5	Lisa y moderadamente gruesa Descamación superficial. 10	Gruesa, rígida surcos superficiales. Descamación superficial. 18	Gruesa y Apergaminada. 22
	FORMA DE LA OREJA.	Plana y sin forma. 0	Inicia engrosamiento del borde. 5	Engrosamiento incompleto sobre mitad anterior. 10	Engrosada e incurvada totalmente. 24	
	TAMAÑO DEL TEJIDO MAMARIO.	No palpable 0	Diámetro 0.5 cm. 5	Diámetro 0.5-1.0 cm. 10	Diámetro >1.0 cm. 15	
	PLIEGUES PLANTARES.	Ausentes 0	Pequeños surcos rojos en mitad anterior. 5	Surcos rojos definidos en mitad ant. Surcos 1/3 anterior. 10	Surcos sobre mitad anterior. 15	Surcos profundos que sobrepasan 1/2 anterior. 20
B SOMATICO Y NEUROLOGICO K= 200 días	SIGNO: "DE LA BUFANDA"	 0	 6	 12	 18	
	SIGNO: "CABEZA EN GOTA".	 0	 4	 8	 12	

2. Capurro B

Este método es el Capurro inicial simplificado por clínicos pediatras y bioestadísticos del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), en el Uruguay y utiliza cinco características físicas externas; suprime los dos parámetros neurológicos (Fig. 2.8). Este es el método ideal que se ha de utilizar si el recién nacido presenta depresión neurológica; presenta un margen de error de ± 9,2 días y los signos que se han de evaluar son los siguientes:

a) Somáticos:

- Forma de la oreja.
- Tamaño de la glándula mamaria.
- Formación del pezón.
- Textura de la piel.
- Pliegues plantares.

Para realizar el cálculo de la edad gestacional, se procede igual al Capurro A, pero utilizando la constante K = 204.
Edad gestacional (días) = 204 + Total de puntos
La edad gestacional en días y en semanas se relacionan entre sí de la forma siguiente:

a) Menos de 259 días o menos de 37 semanas.

b) De 259 a 297 días o entre 37 y 41 semanas.

c) Con 297 días y más o 42 semanas y más.

- Formación del pezón.
- Textura de la piel.
- Forma de pabellón auricular.
- Tamaño del nódulo mamario.
- Surcos plantares

B	Signos					
Somáticos	Formación del pezón	Pezón apenas visible, no aréola 0	Pezón bien definido, aréola < 0,75 cm 5	Aréola punteada no hace relieve > 0,75 cm 10	Aréola hace relieve > 0,75 cm 15	
	Textura de la piel	Fina, gelatinosa 0	Fina, suave 5	Suave, de mediano espesor, descarnación superficial 10	Levemente engrosada, descarnación y grietas superficiales en manos y pies 15	Gruesa como pergamino 20
	Forma del pabellón auricular	Planas sin forma 0	Parte del borde incurvada 8	Parcialmente incurvado en toda la parte superior 16	Bien definida la incurvación del pabellón 24	
	Tamaño del nódulo mamario	Puntiforme o no hay 0	diámetro < 0.5 cm 5	diámetro 0,5 a 1 cm 10	diámetro > 1 cm 15	
K: 204	Surcos plantares	No pliegues 0	Débiles marcas rojas encima de mitad anterior 5	Marcas definidas en mitad anterior, surcos en tercio anterior 10	Surcos en mitad anterior 15	Muescas profundas en más de la mitad anterior 20

Certificante.- Persona autorizada para registrar datos y dar constancia de la autenticidad de los mismos. En el caso que nos ocupa, se constituyen como certificantes autorizados para llenar el Certificado de Nacimiento las siguientes personas: médico con cédula profesional que atiende al nacido vivo; partera tradicional registrada por alguna institución del Sector Salud que atiende el parto y al nacido vivo; médico, enfermera y auxiliar de salud de unidades móviles de Instituciones públicas del Sector Salud.

Certificado.- Documento de acreditación emitido por una entidad o un particular debidamente autorizado. Garantiza que determinado dato pertenece realmente a quien se supone.

Certificado de Nacimiento.- Formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho. El Certificado de Nacimiento es requisito indispensable para el trámite del Acta de Nacimiento y no debe ser confundido con ésta, por lo tanto no puede ser utilizado en sustitución o como complemento de la misma para fines legales o administrativos.

Constancia de hechos.- Registro a través del cual se establece la veracidad y/o autenticidad de algún hecho.

Defunción fetal.- Muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de músculos de contracción voluntaria.

Denuncia de hechos.- Medio a través del cual las personas hacen del conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que puedan constituir un delito.

Estadísticas vitales.- Recuento de hechos o sucesos que le ocurren a la población o a un segmento de ella, los cuales pueden registrarse conforme ocurren, señalando el momento y lugar en que sucedieron. Algunos hechos vitales que se recogen en las estadísticas vitales son: los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios.

Edad gestacional.- Tiempo medido en semanas, transcurrido desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha en que ocurre la expulsión del producto del cuerpo de la madre (ya sea aborto, muerte fetal o nacido vivo). Un embarazo de gestación normal es de aproximadamente 40 semanas, con un rango normal de 38 a 42 semanas.

Emisiones otoacústicas (EOA).- Sonidos generados por las células ciliadas de la coclea que indican función normal de esas estructuras. Pueden registrarse de manera rápida y segura por medio de equipos electroacústicos especiales. Los resultados otorgados por este examen son entregados como PASS (función auditiva normal que no requieren mayor estudio) y REFER (sospecha de hipoacusia o sordera, que requieren de estudios específicos para la confirmación o diagnóstico).

eSINAC.- Sistema electrónico establecido y administrado por la DGIS, que forma parte del componente de nacimientos del Sistema Nacional de Información en Salud, mediante el cual de manera única y exclusiva se expide y valida un CEN.

Gestación.- Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia.

Hipoacusia.- Se refiere a la disminución o pérdida de la capacidad auditiva de una persona, medido en decibeles (db).

Manual.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de organización.

Manual de llenado.- Documento que contiene la información e instrucciones necesarias para el correcto registro de datos en un formato específico, en este caso del Certificado de Nacimiento.

Mola.- Es una masa o tumor poco común, producto de la concepción, que se forma en el interior del útero al comienzo del embarazo. Resulta de la sobreproducción de tejido que se supone forma la placenta, y con frecuencia no existe un feto en absoluto.

Nacido vivo.- Expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de vida como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

Silverman-Andersen.-Indicador del estado de salud respiratoria del nacido vivo. Se valora a los cinco minutos del nacimiento. Evalúa cinco parámetros respiratorios y les asigna un puntaje que va de 0 a 2; la sumatoria de los puntajes de los cinco parámetros arroja la valoración de Silverman-Andersen. Mientras mayor sea el puntaje peor es el pronóstico.

Signo	Puntaje		
	0	1	2
Movimientos Toracoabdominales	Rítmicos y regulares	Tórax inmóvil, abdomen en	Tórax y abdomen en sube y baja
Tiro intercostal	No hay	Discreto	Acentuado y constante
Retracción	No hay	Discreta	Muy marcada
Aleteo nasal	No hay	Discreto	Muy acentuado
Quejido respiratorio	No hay	Leve e inconstante	Constante y acentuado

Sexo.- Característica biológica que distingue a las personas en hombres o mujeres.

Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC).- Forma parte del Sistema Nacional de Información en Salud para la generación de estadísticas reales y oportunas sobre el número de nacimientos que ocurren en el país, minimizando el registro extemporáneo y el subregistro, conociendo mejor los aspectos epidemiológicos de los nacidos vivos y aportando elementos para el seguimiento y evaluación de programas de salud materno-infantil.

Tamiz Auditivo.- Prueba que permite identificar si el nacido vivo presenta sospecha de hipoacusia o sordera; se realiza en forma bilateral con un equipo de Emisiones Otoacústicas (EOA) en base a los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, esto impedirá profundos efectos en el desarrollo cognitivo, del habla y de lenguaje.

Vacuna BCG.- Agente de inmunización activa preparado a partir del bacilo de Calmette-Guérin. Normalmente se prescribe para la inmunización contra la tuberculosis.

Vacuna de Hepatitis B.- Vacuna que se aplica en todo nacido vivo, con un proceso de 3 dosis inyectable (con sus intervalos de tiempo), para prevenir la hepatitis B y las graves consecuencias que esta enfermedad genera como el carcinoma hepatocelular.

Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
CEMECE	Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades
CEN	Certificado Electrónico de Nacimiento
CIE	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud
CLUES	Clave Unica de Establecimientos de Salud
CN	Certificado de Nacimiento
CONAPO	Consejo Nacional de Población
CTESS	Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud
DGIS	Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud
DIF	Desarrollo Integral para la Familia
DOF	Diario Oficial de la Federación
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGS	Ley General de Salud
PEMEX	Petróleos Mexicanos
RMM	Razón de Mortalidad Materna
RENAPO	Registro Nacional de Población e Identificación Personal
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina y Armada de México
SEGOB	Secretaría Gobernación
SESA	Servicios Estatales de Salud
SINAC	Subsistema de Información sobre Nacimientos
SINAIS	Sistema Nacional de Información en Salud
SNS	Sistema Nacional de Salud
TMI	Tasa de Mortalidad Infantil
UM	Unidad Médica

X. Bibliografía

Comité de Información. Dirección General de Tecnología de Información. Centro de Documentación Institucional. Manual para la Operación de Archivos Administrativos. México, 2004.

Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. Ginebra, 1989.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Dirección General de Estadísticas. Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales. Síntesis Metodológica de las Estadísticas Vitales. México, 2003.

Normas y Procedimientos de Neonatología. Versión 2009, publicada por el Instituto Nacional de Perinatología

Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. 10a revisión. Washington, D.C.: OPS, 1995.

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo. Dirección General de Estadística, Informática y Evaluación. Certificado de Nacimiento. México, 1992.

Capítulo 2. EVALUACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL. Dra. Dulce María Reyes Izquierdo

Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Secretaría De Salud. Publicado el 20 de septiembre de 2012.

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

www.salud.gob.mx

www.dgis.salud.gob.mx